



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KEGIATAN

KOMITE MUTU RS. PRIMA HUSADA SUKOREJO

TRIWULAN I TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54,

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN KEGIATAN KOMITE MUTU TRIWULAN I RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2025

Dalam pembangunan sektor kesehatan, salah satu prakondisi yang harus dipenuhi adalah meningkatkan mutu pelayanan, termasuk mutu pelayanan di rumah sakit agar pengelolaan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama oleh direktur dan seluruh stake holder yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disusun Oleh :

Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo

Sukorejo, 31 Maret 2025

Telah Disetujui Oleh :

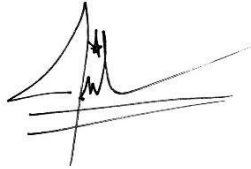
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Kegiatan Komite Mutu Bulan Triwulan I Tahun 2025
Rumah Sakit Prima Husada

Laporan Kegiatan Komite Mutu RS. Prima Husada digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan Rencana perbaikan kinerja maupun layanan di unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada

Disusun,
Oleh ;
Komite Mutu RS. Prima Husada



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP. CHAE.)

Disetujui,
Oleh

Direktur RS. Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Laporan ini berisikan kumpulan dari program kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang menjangkau keseluruhan unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/bagian, keperawatan, penunjang medis, administrasi dan lainnya termasuk kepala unit / instalasi pelayanan.

Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada bulan berikutnya.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh program dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sehingga tersusunnya laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2025. Semoga dengan adanya laporan ini kita dapat meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.2 Tujuan 1

1.2.1 Tujuan Umum 1

1.2.2 Tujuan Khusus 1

BAB II 2

HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU 2

TRIWULAN I TAHUN 2025 2

2.1 Kegiatan Pokok 2

2.2 Kegiatan yang Dilakukan 3

2.3 Jadwal Kegiatan 3

2.4 Pencatatan dan Pelaporan 3

BAB III 4

HASIL KEGIATAN 4

3.1 Pemantauan Indikator Mutu 4

3.1.1 Indikator Mutu Nasional 4

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional 5

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 21

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
24

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit 41

1. INSTALASI GAWAT DARURAT 41

2. INSTALASI RAWAT JALAN 42

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A 43

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B 45

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A 47

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B 48

7. INSTALASI KAMAR OPERASI 50

8. MATERNITAS 52

9. PONEK 54

10. NEONATOLOGI 54

11. ICU 55

12. RADIOLOGI 57

13. LABORATORIUM 57

14. REHAB MEDIS 58

15.	FARMASI	59
16.	GIZI	59
17.	REKAM MEDIS	60
18.	LIMBAH – K3RS	61
19.	SDM	61
20.	KESEKRETARIATAN	62
21.	DRIVER	62
22.	PEMULASARAAN JENAZAH	62
23.	ATEM – IPSRS	63
24.	LAUNDRY	63
25.	CSSD	63
26.	CLEANING SERVICE	64
27.	KEAMANAN	65
28.	GUDANG UMUM	65
29.	PPI	66
30.	PKRS	66
31.	ASURANSI CENTER	67
32.	HUMAS & MARKETING	67
33.	CSO	67
34.	MOD-MPP-PIPP	68
35.	TB di IRJA	68
36.	KEUANGAN	68
37.	TIM HIV	69
38.	KB	69
39.	STUNTING	69
40.	IT - SIM RS	70
BAB IV		Error! Bookmark not defined.
HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM MUTU LAINNYA ..		Error! Bookmark not defined.
4.1	Prorgram Sasaran Keselamatan Pasien	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi RS Prima Husada Sukorejo adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi RS Prima Husada Sukorejo, maka ditetapkan tiga misi sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat, (2) mengutamakan kepuasan pasien, (3) meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Untuk memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien RS Prima Husada Sukorejo melakukan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang sesuai dengan Standar Akreditasi Nasional. Kegiatan ini dilakukan di semua unit kerja untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit sesuai standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dari KARS STARKES berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikannya indikator rumah sakit sebagai berikut : Indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas Rumah sakit (IMP-RS) yang meliputi : indikator sasaran keselamatan pasien, indikator pelayanan klinis prioritas, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, indikator terkait perbaikan sistem dan indikator terkait manajemen resiko, kemudian yang ketiga yakni insikator mutu prioritas unit.

Identifikasi prosedur, proses dan hasil dari kegiatan yang dinilai sebelumnya pada tahun 2024, disertai tujuan untuk menekan permasalahan yang ada di rumah sakit mendasari dipilihnya indikator baru di indikator prioritas. Kriteria pemilihan tetap didasarkan pada kasus yang memiliki volume tinggi, resiko tinggi atau biaya tinggi, disesuaikan dengan visi dan misi rumah sakit. Laporan Komite Mutu Triwulan I Tahun 2025 indikator mutu yang diambil oleh unit kerja.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di setiap unit di RS Prima Husada Sukorejo

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi peningkatan mutu RS Prima Husada Sukorejo melalui pemantauan indikator mutu internal atau eksternal berdasarkan standar Komite Mutu Tahun 2022
2. Mengevaluasi program keselamatan pasien dengan pemantauan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit (IKP-RS)
3. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu lain, yang dilakukan oleh unit terkait dengan peningkatan mutu yakni :
 - a. Program manajemen resiko
 - b. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit kerja
4. Menganalisis capaian indikator mutu unit untuk mendapatkan bahan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut perbaikan di unit

BAB II
HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Kegiatan Pokok

Seperti yang dijelaskan di atas, kegiatan pemantauan indikator mutu Komite Mutu Tahun 2025 yang dilaporkan adalah periode bulan Triwulan I Tahun 2025. Adapun indikator mutu yang dipantau adalah sebagai berikut:

A) Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan
2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
3. Kepatuhan Identifikasi Pasien
4. Waktu Tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit
5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit
6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit
7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00
8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit
9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)
11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh
12. Keterlambatan Respon Terhadap Komplain
13. Kepuasan Pasien

B) Indikator Mutu Prioritas

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien
 - b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR
 - c. Kepatuhan Pengembalian Obat Sisa Anestesi & Narkotika ke Ruang Farmasi
 - d. Kepatuhan Pelaksanaan *Surgical Safety Checklist* (SSC)
 - e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi
 - f. Kepatuhan Kebersihan Tangan
 - g. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
 - a. Ketepatan pemberian MgSO₄ Pada Pasien PEB
 - b. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS
 - c. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.
 - d. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium.
 - e. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan
 - f. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol
 - g. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA_{1c} $<7\%$
 - h. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)
 - i. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor
 - j. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $<140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis
3. Indikator Berdasarkan Renstra RS
 - a. Kepuasan pasien
4. Indikator Perbaikan Sistem
 - a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi
 - b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO
 - c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi
5. Indikator Manajemen Resiko
 - a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran
 - b. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal
6. Praktik Klinis yang Di Evaluasi (17 Diagnosis yang di evaluasi)
 - 1) CVA
 - 2) Batu Ureter
 - 3) Diabetes Millitus

- 4) GEA
- 5) HIV
- 6) Hipertensi
- 7) TB
- 8) Keganasan (Ca Mammae)
- 9) Pneumonia
- 10) SC
- 11) Partus Normal
- 12) PEB
- 13) BPH
- 14) Hydronefrosis
- 15) PPOK
- 16) Fraktur terbuka
- 17) Stroke hemoragik
- 18) Stroke Trombosis

2.2 Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan analisis hasil capaian mutu indikator di unit kerja
3. Melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian atau mencapai target yang ditentukan
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu di unit kerja
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

2.3 Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu di unit kerja secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu (dilakukan setiap bulan)
3. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator di unit kerja setiap bulan, serta menyusun program perbaikan mutu dengan teknik PDSA oleh penanggungjawab pengumpul data unit di koordinasikan dengan komite Mutu
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap satu bulan.
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo dengan hasil banchmarking perbandingan capaian mutu dengan RS lain setiap tiga bulan sekali.

2.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh penanggungjawab data mutu unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab. Data hasil pemantauan ditulis pada form laporan harian mutu dan dilakukan validasi kepada kepala unit untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah benar dan valid. Jika data sudah valid selanjutnya akan dilakukan analisis data untuk mencari rencana tindak lanjut bagi indikator mutu yang masih belum mencapai target atau standar yang ditetapkan. Hasil pengolahan dan analisis data dituangkan dalam laporan tertulis kemudian akan dilaporkan kepada penanggungjawab mutu rumah sakit setiap bulan dalam rapat koordinasi mutu bulanan.

Penanggung jawab mutu Rumah Sakit selanjutnya akan menentukan langkah untuk membuat rencana tindak lanjut indikator mutu yang belum sesuai targert sebagai bentuk feedback dari pelaporan penanggung jawab mutu di unit.

BAB III
HASIL KEGIATAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu

Berikut merupakan hasil pemantauan indikator mutu RS. Prima Husada Sukorejo yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025.

3.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

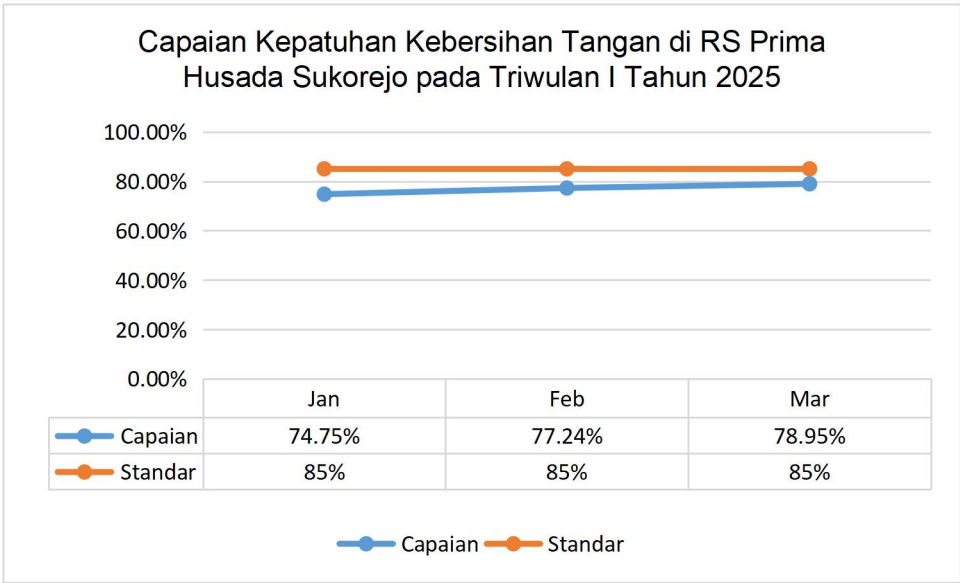
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Bulan Triwulan I Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		Januari	Februari	Maret			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	74,75%	77,24%	78,95%	≥85%	76,98%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	89,64%	89,87%	84,84%	100%	88,12%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	98,30%	99,76%	99,66%	100%	99,24%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	95,45%	92,31%	100%	≥80%	95,92%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	71,25%	68,24%	45,81%	≥80%	61,77%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	0%	3,43%	1,08%	≤5%	1,50%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	71,77%	72,57%	76,56%	≥80%	73,63%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan

10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,70%	96,98%	98,70%	≥80%	98,46%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	95,95%	96,65%	96,25%	100%	96,28%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	≥76.61%	94,41%	Dipertahankan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan I yakni mencapai 76,98%. Terlihat adanya tren peningkatan dari waktu ke waktu yaitu dari 74,75% pada bulan Januari menjadi 78,95% pada Bulan Maret 2025. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu ≥85%.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada bulan Triwulan I < 85% yakni 76,98%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target ≥85%, dengan rata-rata kepatuhan saat ini sebesar 76,98%. 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan menjadi ≥85% dalam 3 bulan. 3. Rencana Aksi: a. Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai

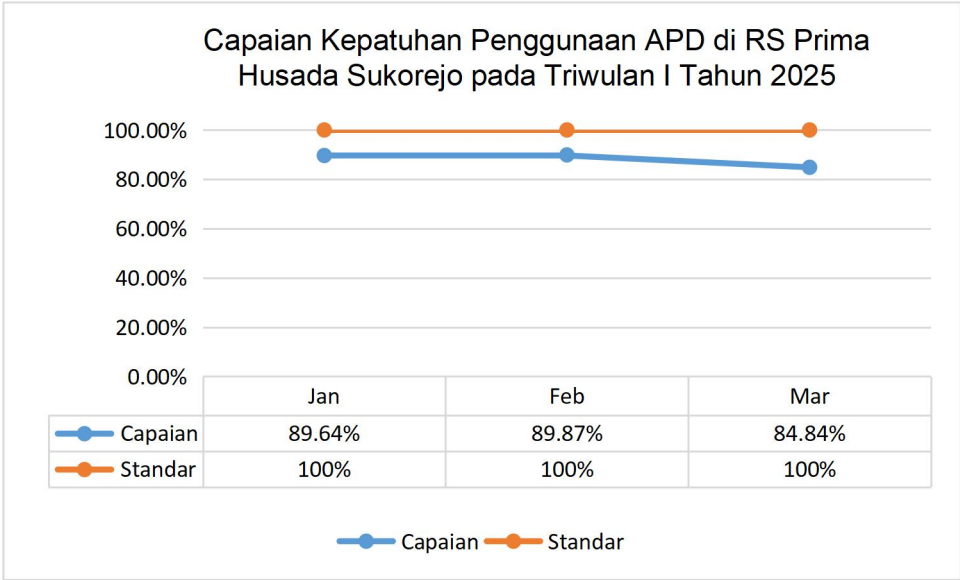
	pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO. - Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan. - Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI - Memberikan umpan balik langsung dan bersifat konstruktif kepada tenaga kesehatan. - Memberikan penghargaan kepada individu atau unit kerja dengan tingkat kepatuhan tertinggi. - Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.
Do	- Edukasi ulang dilaksanakan kepada seluruh tenaga kesehatan pada awal bulan - Poster, banner atau video ditempatkan di ruang perawatan, IGD, dan poli rawat jalan - Supervisi awal dilakukan oleh Tim PPI untuk memastikan pelaksanaan edukasi berjalan baik.
Study	- Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan bulan Triwulan I 2025 yaitu 76,98% - Terlihat adanya tren peningkatan dari waktu ke waktu yaitu dari 74,75% pada bulan Januari menjadi 78,95% pada Bulan Maret 2025 - Target 85% belum tercapai - Edukasi dan media edukatif memberikan dampak positif, namun belum cukup signifikan - Analisa Penyebab: - Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO - Belum semua staf mengikuti edukasi Kepatuhan Kebersihan Tangan di Tahun 2025
Action	- Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO. - Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan. - Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI - Memberikan penghargaan kepada individu atau unit kerja dengan tingkat kepatuhan tertinggi. - Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO.	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>) agar mencapai target $\geq 85\%$, guna mencegah infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) dan meningkatkan mutu pelayanan.	Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pelayanan pasien, termasuk dokter, perawat, bidan, analis, dan tenaga pendukung lain.	Memberikan pelatihan ulang tentang pentingnya kebersihan tangan dan implementasi <i>5 Moments</i> WHO secara periodik.	Komite PPI	Satu bulan
2	Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap	Seluruh area kerja dan ruang perawatan	Pemasangan media edukasi visual seperti poster,	Komite PPI	Satu bulan

	video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan.	kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>)	terdapat media edukasi kebersihan tangan	banner, atau video di area rawan infeksi.		
3	Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Melakukan observasi langsung terhadap praktik kebersihan tangan dan memberikan umpan balik individual/unit.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Memberikan umpan balik langsung dan bersifat konstruktif kepada tenaga kesehatan.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
5	Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>)	Petugas dengan tingkat kepatuhan rendah	Pembinaan kepada unit dengan kepatuhan rendah.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Triwulan I yakni mencapai 88,12%. Terlihat adanya penurunan pada Bulan Maret 2025 yakni 84,84%. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

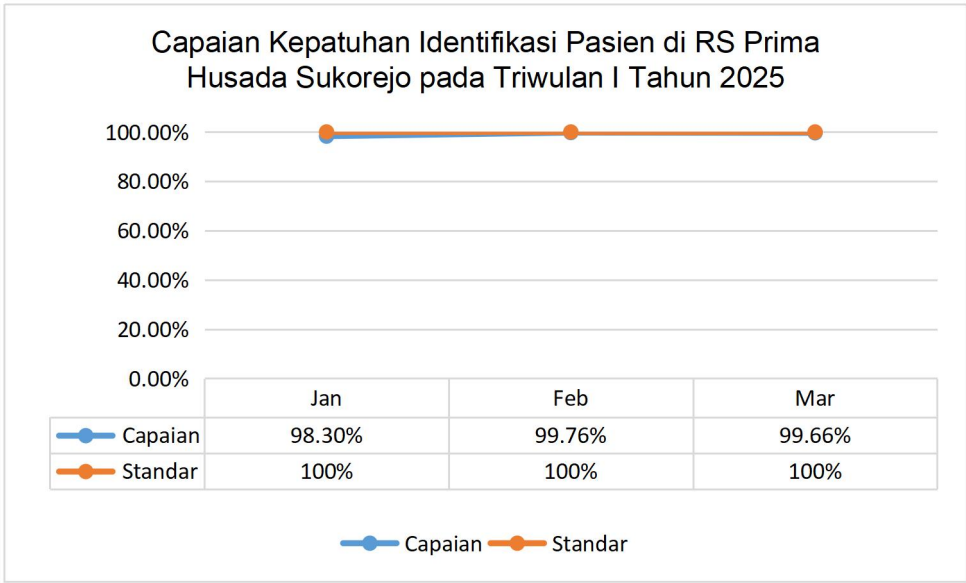
Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 88,12%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 88,12%. Bahkan terjadi penurunan pada Bulan Maret Tahun 2025 (84,84%) 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD menjadi 100% dalam 3 bulan mendatang untuk mencegah infeksi dan menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. 3. Rencana Aksi: a. Edukasi ulang terkait pentingnya penggunaan APD dan jenis-jenis APD sesuai risiko. b. Penempatan reminder visual di setiap ruangan tindakan. c. Supervisi harian oleh kepala ruangan dan Tim PPI. d. Pemantauan ketersediaan APD secara ketat oleh logistik.
Do	1. Edukasi dilaksanakan kepada seluruh tenaga kesehatan selama minggu pertama dan kedua. 2. Poster dan stiker edukasi APD dipasang di ruang perawatan, IGD, laboratorium, dan ruang tindakan. 3. Tim PPI dan kepala ruangan melakukan inspeksi harian mengenai penggunaan APD. 4. Koordinasi dilakukan dengan tim logistik untuk menjamin ketersediaan APD tanpa hambatan.
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 88,12% 2. Terjadi penurunan signifikan di Bulan Maret yakni 84,84% 3. Adapun yang tidak mencapai standar dikarenakan: a. Ditemukan perawat yang tidak menggunakan <i>handscoon</i> saat sebelum tindakan ke pasien b. Ditemukan perawat yang menggunakan <i>handscoon</i> saat membawa troli dari nurse station setelah tindakan dari pasien (tidak membuang <i>handscoon</i> terlebih dahulu). c. Ditemukan petugas laboratorium tidak menggunakan gown di area sampling.
Action	1. Membuat sistem “checklist penggunaan APD” yang ditandatangani sebelum dan sesudah tindakan. 2. Poster dan stiker edukasi APD dipasang di ruang perawatan, IGD, laboratorium, dan ruang tindakan. 3. Memberikan apresiasi unit dengan kepatuhan terbaik dan laporan per bulan. 4. Mengkaji kembali kenyamanan APD dan memberi opsi sesuai standar (contoh: masker medis non-iritasi, sarung tangan <i>hypoallergenic</i>).

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Membuat sistem “checklist penggunaan APD” yang ditandatangani sebelum dan sesudah tindakan.	Untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD sesuai standar.	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Sosialisasi penggunaan checklist ke seluruh unit dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan checklist oleh kepala	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

				ruangan dan Tim PPI.		
2	Poster dan stiker edukasi APD dipasang di ruang perawatan, IGD, laboratorium, dan ruang tindakan	Memberikan informasi cepat dan jelas terkait tata cara penggunaan APD sesuai standar.	All ruangan	Mendesain media edukasi (poster, stiker atau video) dengan visual menarik, jelas, dan mudah dipahami.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Memberikan apresiasi unit dengan kepatuhan terbaik dan laporan per bulan	Meningkatkan motivasi dan semangat kompetitif antar unit kerja dalam menjaga kepatuhan penggunaan APD.	Unit kerja pelayanan langsung yang menjadi objek audit kepatuhan penggunaan APD	Melakukan audit kepatuhan penggunaan APD secara rutin setiap bulan oleh Tim PPI.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Mengkaji kembali kenyamanan APD dan memberi opsi sesuai standar (contoh: masker medis non-iritasi, sarung tangan <i>hypoallergenic</i>).	Menyediakan pilihan APD yang tetap memenuhi standar keselamatan namun lebih ramah bagi pengguna.	Tenaga kesehatan di semua unit pelayanan yang menggunakan APD secara rutin dan intensif.	Monitoring dan evaluasi	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

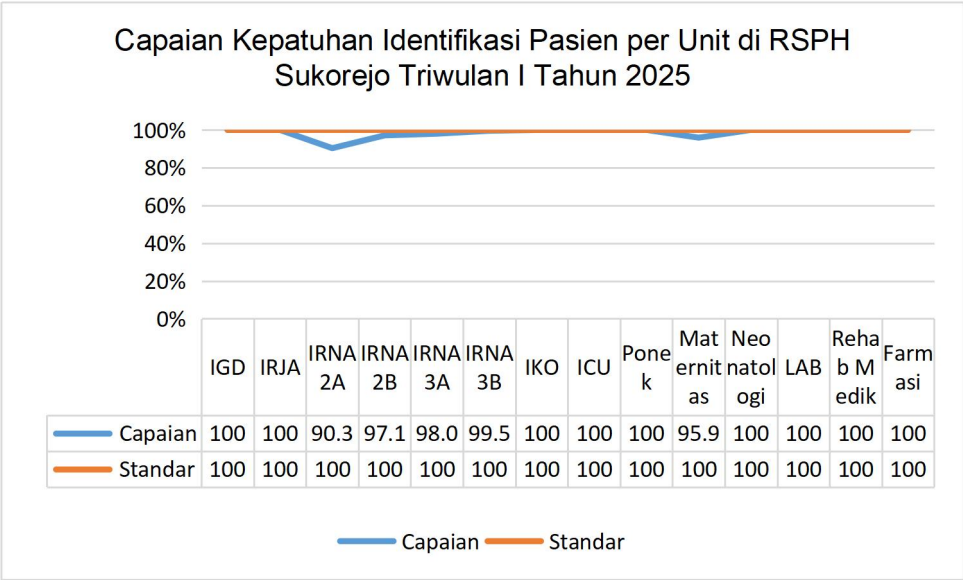


Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Triwulan I Tahun 2025 mecapai 99,24%. Kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menunjukkan tren sangat baik dan stabil. Pada awal periode, capaian berada di angka 98,30%, kemudian meningkat

signifikan hingga mencapai 99,76% dan konsisten di atas 99% pada bulan-bulan berikutnya. Puncaknya, pada salah satu bulan, tercatat kepatuhan hampir mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh tenaga kesehatan melakukan identifikasi pasien sesuai standar (menggunakan dua identitas).



Gambar 3.4. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien per unit di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan terdapat 5 unit kepatuhan identifikasi pasien yang tidak mencapai standar yakni Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A) sebesar 90,32%, Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B) sebesar 97,11%, Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) sebesar 98,00%, IRNA 3B 99,55% dan Maternitas sebesar 95,90%. Berdasarkan hasil observasi di Instalasi Rawat Inap 2A dari 310 petugas yang di observasi ditemukan 30 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, yakni 17 petugas yang tidak melakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja dan 13 petugas yang tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan kembali nama pasien, TTL). Adapun di Instalasi Rawat Inap 2B dari 450 petugas yang di observasi ditemukan 13 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, yakni 11 petugas tidak identifikasi secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) tetapi dilakukan secara lisan saja dan dan 2 petugas yang tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan kembali nama pasien, TTL). Adapun di Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) dari 450 petugas yang di observasi ditemukan 9 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja. Adapun di Instalasi Rawat Inap 3B dari 449 petugas yang di observasi ditemukan 2 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat antara etiket dan uji fungsi pasien) hanya lisan saja. Adapun di Maternitas dari 439 petugas di observasi ditemukan 18 petugas yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja.

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan I Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan I Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,24%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 5 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu: - IRNA 2A – 90,32% Dari 310 petugas yang diobservasi, 30 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 17 petugas tidak melakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas) 13 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) - IRNA 2B – 97,11% Dari 450 petugas yang diobservasi, 13 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur:

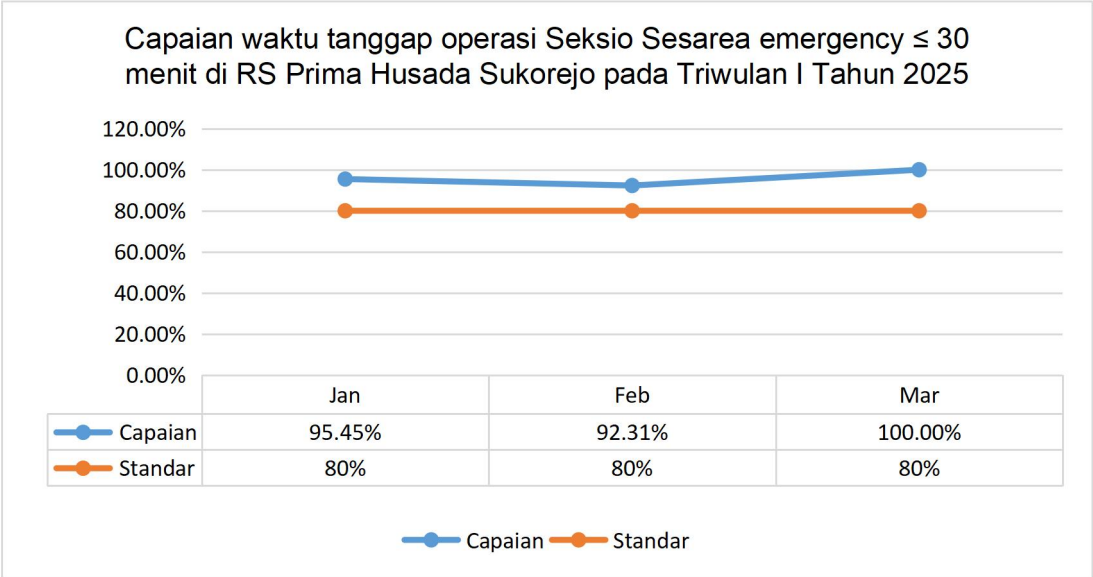
	a. 11 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) b. 2 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) 3. IRNA 3A – 98,00% Dari 450 petugas yang diobservasi, 9 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 9 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 4. IRNA 3B – 99,55% Dari 450 petugas yang diobservasi, 2 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 2 petugas tidak identifikasi visual (Kekeliruan Pemeriksaan Uji Fungsi Pleura) 5. Maternitas – 95,90% Dari 439 petugas yang diobservasi, 18 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 18 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) Akar Masalah yang teridentifikasi : 1. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP 2. Kurangnya pemahaman pentingnya prosedur identifikasi pasien 3. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual 4. Minimnya pengawasan langsung dari kepala ruangan Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : a. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien b. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh c. Tindak lanjut hasil koordinasi untuk dilakukan pelatihan maupun refresh ulang SPO identifikasi pasien dengan PJ Tim SKP d. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan identifikasi pasien pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 99,24% 2. Sebanyak 5 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu: a. IRNA 2A – 90,32% Dari 310 petugas yang diobservasi, 30 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 17 petugas tidak melakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas) 2) 13 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) b. IRNA 2B – 97,11% Dari 450 petugas yang diobservasi, 13 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 11 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 2) 2 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) c. IRNA 3A – 98,00% Dari 450 petugas yang diobservasi, 9 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 9 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) d. IRNA 3B – 99,55% Dari 450 petugas yang diobservasi, 2 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 2 petugas tidak identifikasi visual (Kekeliruan Pemeriksaan Uji Fungsi Pleura) e. Maternitas – 95,90% Dari 439 petugas yang diobservasi, 18 petugas tidak melakukan identifikasi

	sesuai prosedur: 1) 18 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 3. Adapun yang tidak mencapai standar dikarenakan: a. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP b. Kurangnya pemahaman pentingnya prosedur identifikasi pasien c. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual d. Minimnya pengawasan langsung dari kepala ruangan
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Triwulan I tahun 2025 mencapai 99,24%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pendataan dan rekap nama-nama petugas yang tidak melakukan prosedur identifikasi pasien dengan benar selama proses observasi. 2. Menyusun jadwal koordinasi dengan masing-masing petugas yang teridentifikasi tidak patuh (Koordinasi dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab mutu ruangan, secara individu atau kelompok kecil) 3. Tindak lanjut koordinasi dengan pelatihan dan refresh SPO dengan melibatkan Penanggung Jawab Tim Sasaran Keselamatan Pasien (PJ Tim SKP) 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rekap nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Mengidentifikasi petugas yang tidak menjalankan prosedur dengan benar	Petugas dari all unit pelayanan	Mengolah data observasi, membuat daftar nama & unit	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
2	Penjadwalan koordinasi dengan petugas tidak patuh	Melakukan pendekatan personal dan klarifikasi	Petugas yang terdata tidak patuh	Koordinasi secara individu atau kelompok kecil di ruangan masing - masing	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
3	Refresh training & pembahasan ulang SPO Identifikasi pasien	Memberikan pemahaman ulang terkait prosedur identifikasi dua langkah	Seluruh petugas di unit yang tidak patuh	Edukasi kelompok, diskusi SOP, simulasi sederhana	J Tim SKP, SDM Diklat, Kepala Ruangan	Satu bulan
4	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

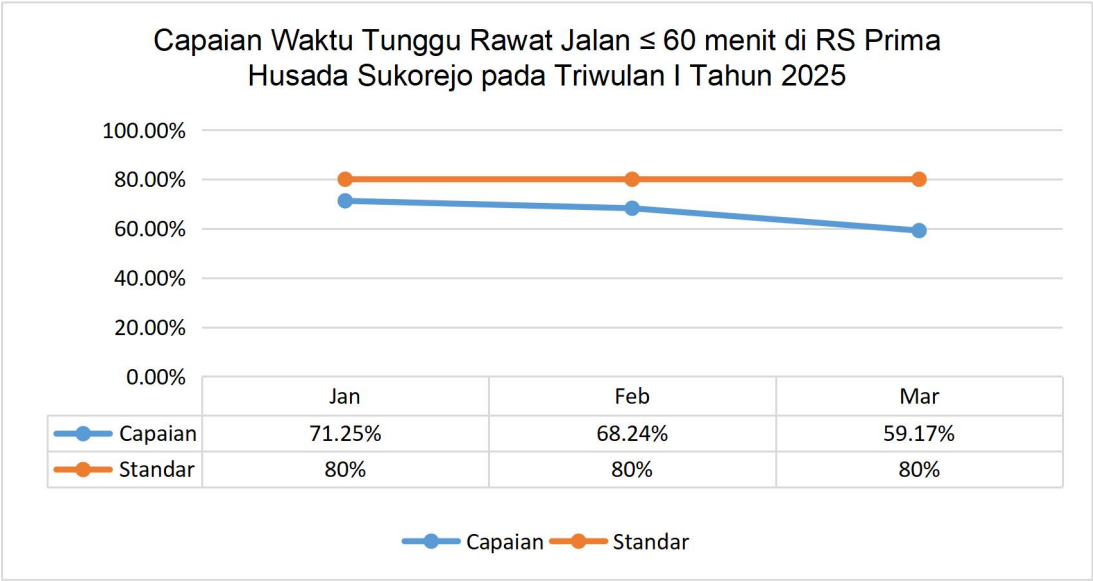


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai standar yakni dengan rata-rata 95,92%. Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dan tindakan kurang dari 30 menit, sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 66,22%. Dari 285 kedatangan pasien yang di observasi ditemukan 99 pasien yang harus menunggu ≥ 60 menit. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 36 menit.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan I Tahun 2025

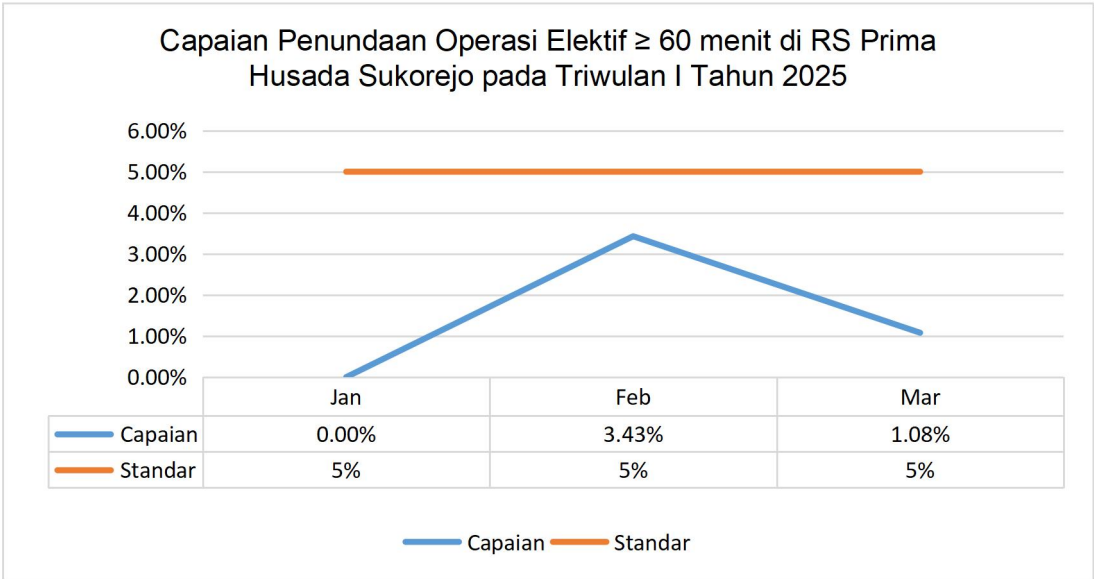
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 66,22% dan belum mencapai target 80%. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan yakni 1 jam 36 menit jauh melebihi standar maksimal 60 menit.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan
Plan	Masalah yang ditemukan : Mengurangi waktu tunggu rawat jalan di poli > 60 menit

	Tujuan : Meningkatkan persentase kepatuhan standar waktu tunggu ≤ 60 menit menjadi minimal 80% pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi: 1. Koordinasi dengan dokter agar datang tepat waktu sesuai jadwal praktik. 2. Sosialisasi kepada pasien untuk datang sesuai jadwal dan pentingnya reservasi sebelumnya.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Memonitor waktu kedatangan dokter dan jumlah pasien menumpuk di awal waktu praktik. 2. Melakukan edukasi kepada seluruh petugas front office dan pendaftaran tentang pentingnya efisiensi waktu tunggu.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan Triwulan I yakni 66,22% belum mencapai $\geq 80\%$. 2. Dari 285 kedatangan pasien yang di observasi ditemukan 99 pasien yang harus menunggu ≥ 60 menit. 3. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 36 menit. Ini dikarenakan: a. Adanya penumpukan pasien di awal jam poli b. Adanya dokter yang terlambat dari jadwal praktik
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit yakni 66,22% belum mencapai $\geq 80\%$. Rata-rata keterlambatan terjadi dalam waktu 1 jam 36 menit. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan dokter agar datang tepat waktu sesuai jadwal praktik. 2. Sosialisasi kepada pasien untuk datang sesuai jadwal dan pentingnya reservasi sebelumnya.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan dokter agar datang tepat waktu sesuai jadwal praktik	Mengurangi waktu tunggu awal poli	Dokter Poli Rawat Jalan	Rapat koordinasi dengan Kabid Pelayanan & Komite Medik	Kabid Pelayanan & Komite Medik	Satu bulan
2	Sosialisasi kepada pasien untuk datang sesuai jadwal dan pentingnya reservasi sebelumnya	Meningkatkan efisiensi dan pelayanan awal	CSO, Pendaftaran & Poli Rawat Jalan	Pelatihan petugas Pendaftaran, CSO, dan Perawat Poli	SDM Diklat, Komite Medik, Komite Mutu	Satu bulan

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

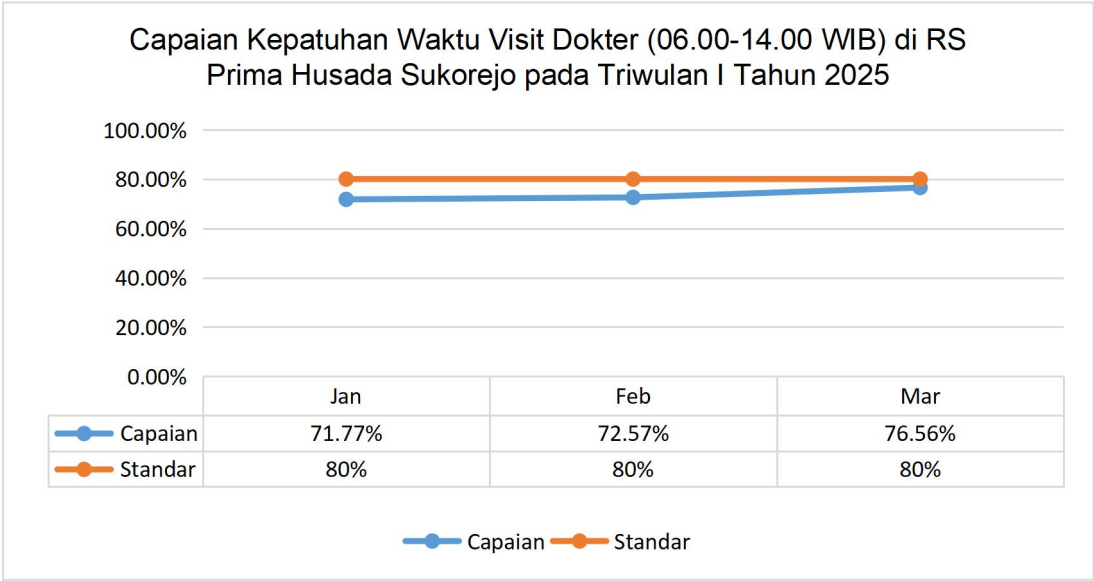


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I tahun 2025 yakni 1,5%. Capaian ini sudah mencapai standar < 5 %.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap mencapai 73,63% dan masih dibawah standar ≥ 80%. Adanya tren meningkat dari Bulan Januari ke Bulan Maret 2025 tapi masih perlu perbaikan untuk mencapai target mutu.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 adalah 73,63 belum mencapai target ≥80%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter

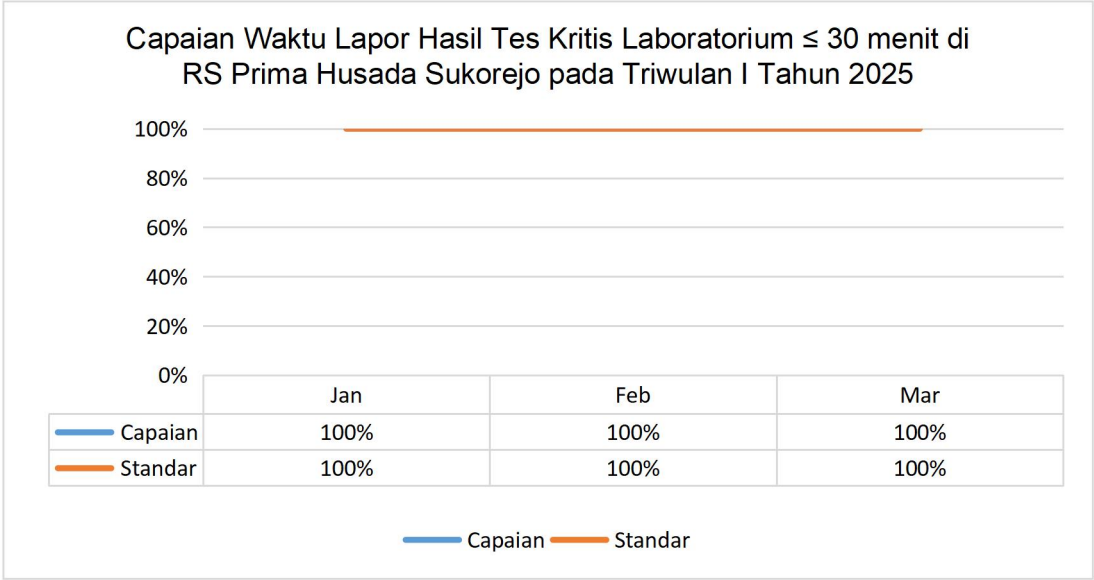
Plan	Identifikasi Masalah : 1. Capaian kepatuhan waktu visit dokter spesialis masih di bawah standar (rata-rata triwulan I: 73,63%) 2. Masih ditemukan dokter yang tidak melakukan visit rutin, tidak ada bukti dokumentasi di rekam medis. 3. Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. 4. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif). Tujuan : 1. Meningkatkan kepatuhan visit dokter menjadi minimal 80%. Rencana Aksi: 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat).
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? 1. Pelaksanaan Visit Rutin Sesuai Jam yang Ditentukan (Pagi ≤ 14.00 WIB) 2. Waktu visit dicatat dalam rekam medis dan checklist visit. 3. DPJP mengisi form/checklist visit dengan tanda tangan/paraf sebagai bukti kunjungan.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 73,63%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai ≥ 80%. Ini dikarenakan: 1. Masih ditemukan dokter yang tidak melakukan visit rutin, tidak ada bukti dokumentasi di rekam medis. 2. Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB 3. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif).
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 73,63%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai ≥ 80%. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat).

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana a	Waktu
1	Audit harian oleh kepala ruangan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang datang ≥ 14.00	Rapat koordinasi dengan komite medik	Kepala Ruang	Satu bulan
2	Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Seluruh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di rumah sakit	Rapat Koordinasi dengan SDM	Komite Medik & SDM	Satu bulan

	sehingga mempengaruhi OPPE dokter					
3	Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk tercatat) &	Menjamin kontinuitas pelayanan medis melalui penggantian DPJP saat cuti	Dokter Penanggung jawab Pasien	Menetapkan DPJP pengganti resmi saat dokter cuti, dan mendokumentasikannya secara formal.	Kepala Bidang Pelayanan	Satu bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit

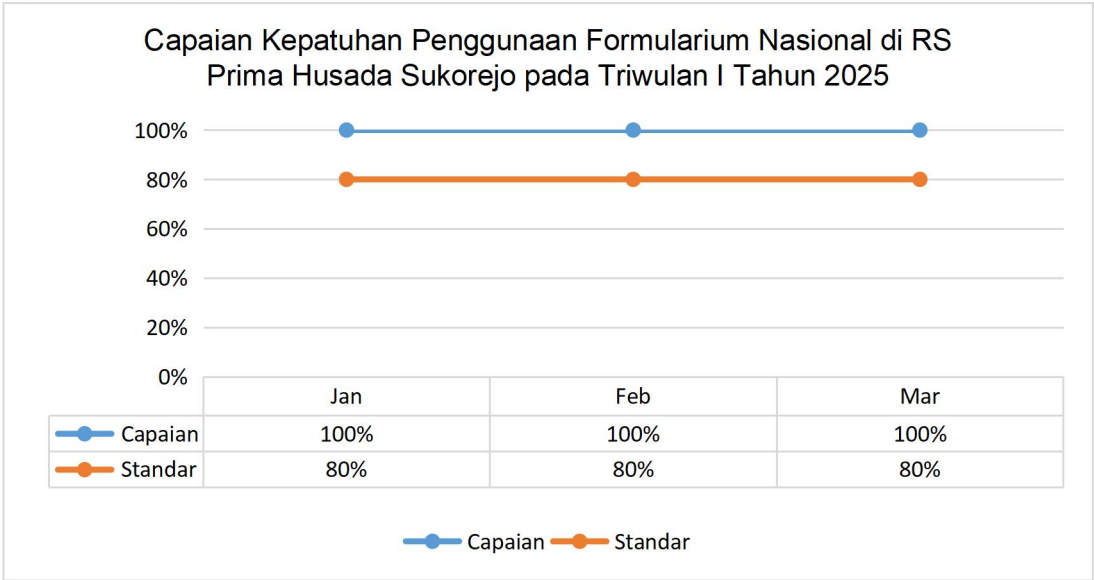


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari 983 hasil kritis laboratorium di observasi, 983 hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

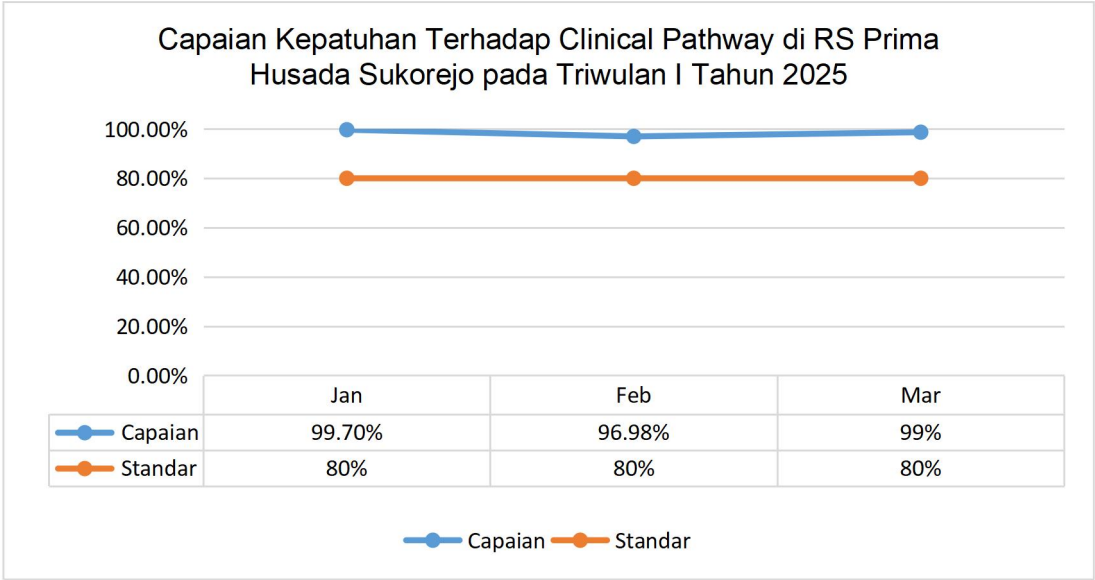


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan persepsan obat hanya dari Formularium Nasional.

10.Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

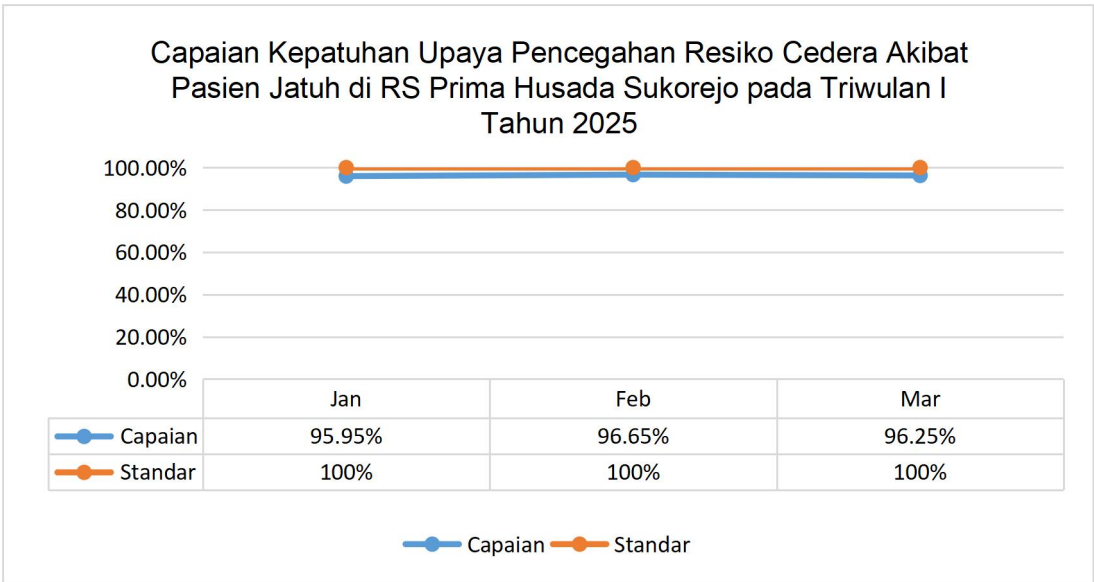


Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Triwulan I Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 98,46%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway bulan Triwulan I didapatkan dari diagnosa Pneumonia, PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11.Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Triwulan I tahun 2025 adalah

96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 4923 petugas yang di observasi ditemukan 183 petugas tidak patuh dari pencegahan resiko jatuh.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

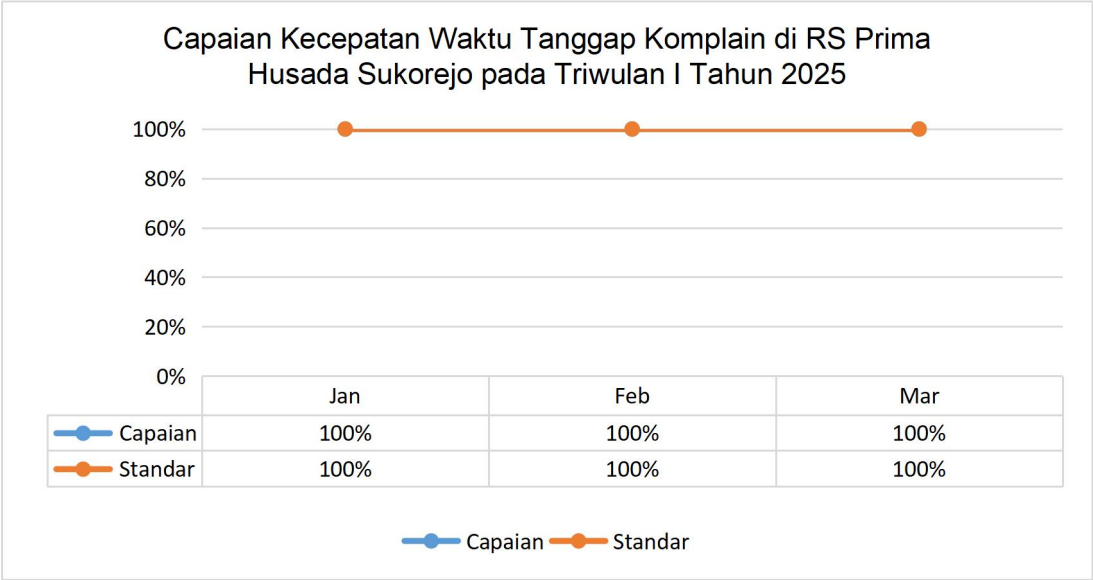
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Identifikasi Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 96,28% 2. Ketidaksesuaian antara SPO dan penerapan petugas terkait Pencegahan Resiko Jatuh 3. Tanda resiko jatuh tidak terpasang di kursi roda 4. Hand rail hanya terpasang di salah satu bed pasien Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Koordinasi dengan kepala ruangan dan Tim SKP untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko jatuh 2. Pelatihan oleh Tim SKP terkait perhitungan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Ketidaksesuaian antara SPO dan penerapan petugas terkait Pencegahan Resiko Jatuh 2. Tanda resiko jatuh tidak terpasang di kursi roda 3. Hand rail hanya terpasang di salah satu bed pasien 1.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan I Tahun 2025 belum sesuai standar yakni Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruangan dan Tim SKP untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko jatuh 2. Pelatihan oleh Tim SKP terkait perhitungan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan kepala ruangan dan Tim SKP untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko	Mengurangi ketidakpatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Seluruh staff yang tidak patuh dalam upaya resiko jatuh dapat ditindak lanjuti oleh Tim SKP	Koordinasi dengan Tim SKP	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan

	jatuh					
2	Pelatihan oleh Tim SKP terkait perhitungan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang	Mengurangi ketidakpatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Seluruh staff yang tidak patuh memiliki pengetahuan yang meningkat dan kepatuhan 100%	Pelatihan dengan menggunakan uji coba praktek langsung perhitungan cara skrinning awal dan skrinning ulang resiko jatuh	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

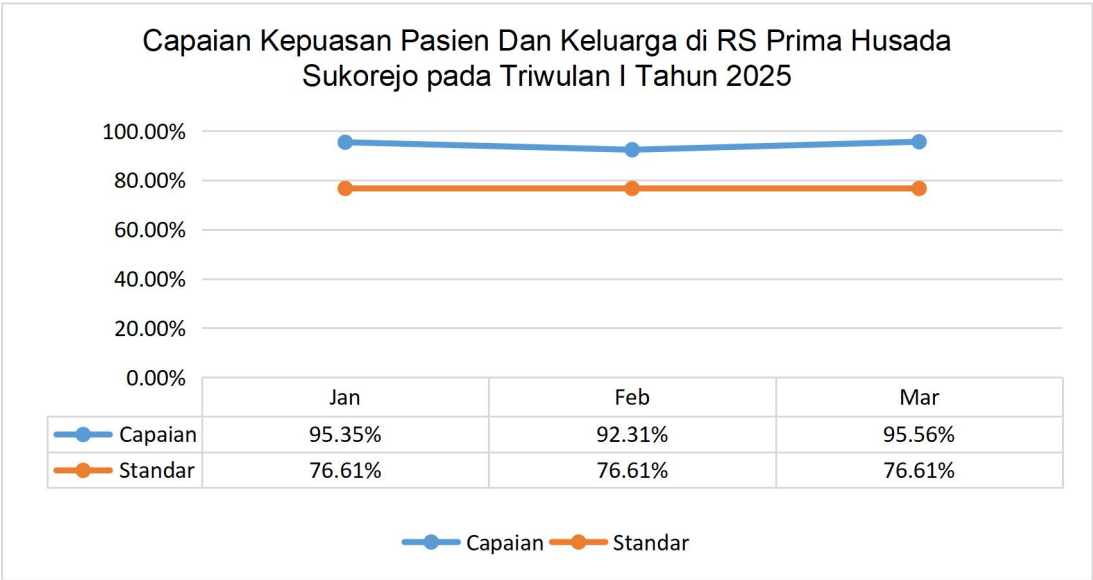


Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan I Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 94,41%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

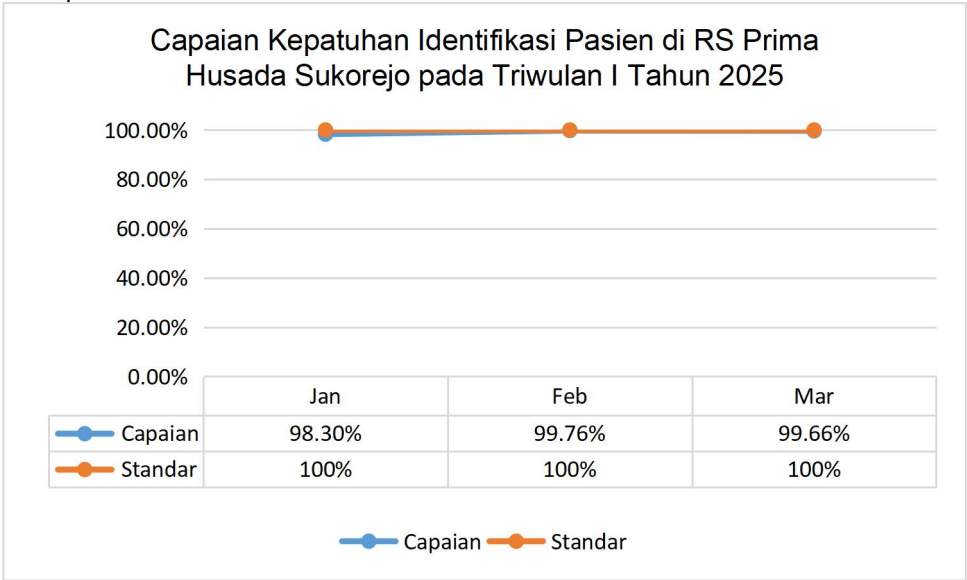
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Januari	Februari	Maret			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	98,30%	99,76%	99,66%	100%	99,24%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	93,10%	96,31%	96,35%	100%	95,25%	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada Obat Sisa Anestesi
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		b. Kejadian tidak dilakukannya penandaan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Januari	Februari	Maret			
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: b. Kepatuhan Kebersihan Tangan	74,75%	77,24%	78,95%	100%	76,98%	PDSA
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	95,95%	96,65%	96,28%	100%	96,30%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Ketepatan pemberian MgSO ₄ Pada Pasien PEB	100%	85,71%	100%	100%	95,24%	PDSA
		2. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS				100%		Belum diisi
		3. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		Belum diisi
		4. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		Belum diisi
		5. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah	0%			≤5%		Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			Januari	Februari	Maret			
		pengobatan						
		6. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
		7. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	11,11%			≥ 70%		PDSA
		8. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		Belum diisi
		9. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		Belum diisi
		10. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis	24,10%			≥ 75 %		PDSA
3	Renstra RS	1. Kepuasan pasien	95,35%	92,31%	95,56%	≥ 76,61 %	94,41%	Dipertahankan
4	Perbaikan Sistem	1. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		3. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Manajemen Resiko	1. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	17 Kejadian	7 kejadian	4 kejadian	0 Kejadian	9 kejadian	PDSA
		2. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

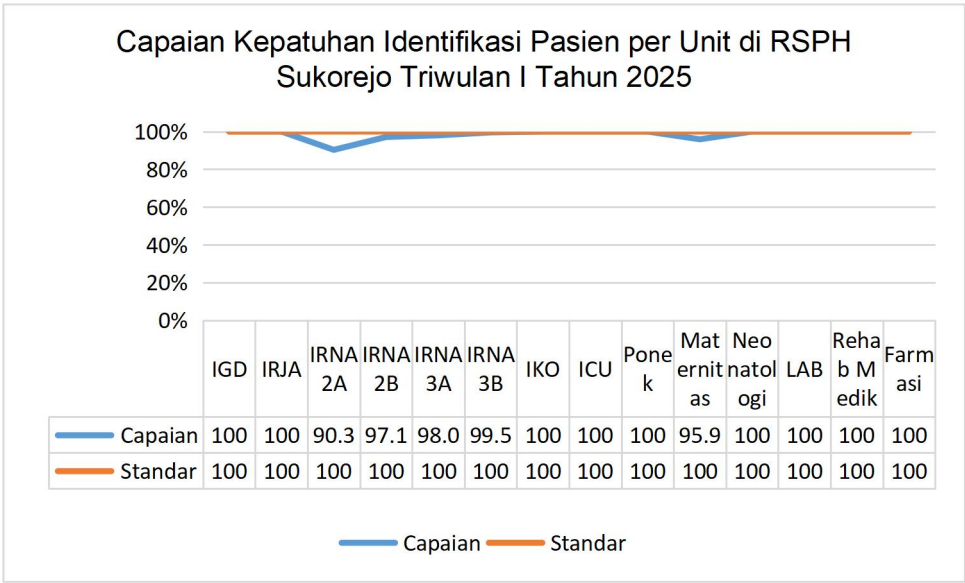
- 1. Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.15. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Triwulan I Tahun 2025 mencapai 99,24%. Kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan identifikasi pasien menunjukkan tren sangat baik dan stabil. Pada awal periode, capaian berada di angka 98,30%, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 99,76% dan konsisten di atas 99% pada bulan-bulan berikutnya. Puncaknya, pada salah satu bulan, tercatat kepatuhan hampir mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh tenaga kesehatan melakukan identifikasi pasien sesuai standar (menggunakan dua identitas).



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien per unit di RS Prima Husada Sukorejo Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan terdapat 5 unit kepatuhan identifikasi pasien yang tidak mencapai standar yakni Instalasi Rawat Inap 2A (IRNA 2A) sebesar 90,32%, Instalasi Rawat Inap 2B (IRNA 2B) sebesar 97,11%, Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) sebesar 98,00%, IRNA 3B 99,55% dan Maternitas sebesar 95,90%. Berdasarkan hasil observasi di Instalasi Rawat Inap 2A dari 310 petugas yang di observasi ditemukan 30 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, yakni 17 petugas yang tidak melakukan secara visual

(tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja dan 13 petugas yang tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan kembali nama pasien, TTL). Adapun di Instalasi Rawat Inap 2B dari 450 petugas yang di observasi ditemukan 13 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar, yakni 11 petugas tidak identifikasi secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) tetapi dilakukan secara lisan saja dan 2 petugas yang tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan kembali nama pasien, TTL). Adapun di Instalasi Rawat Inap 3A (IRNA 3A) dari 450 petugas yang di observasi ditemukan 9 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja. Adapun di Instalasi Rawat Inap 3B dari 449 petugas yang di observasi ditemukan 2 petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat antara etiket dan uji fungsi pasien) hanya lisan saja. Adapun di Maternitas dari 439 petugas di observasi ditemukan 18 petugas yang tidak dilakukan identifikasi pasien dengan benar dengan tidak dilakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas pasien) hanya lisan saja.

Tabel 3.16. PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Triwulan I Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan I Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,24%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 5 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu: 1. IRNA 2A – 90,32% Dari 310 petugas yang diobservasi, 30 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 17 petugas tidak melakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas) b. 13 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) 2. IRNA 2B – 97,11% Dari 450 petugas yang diobservasi, 13 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 11 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) b. 2 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) 3. IRNA 3A – 98,00% Dari 450 petugas yang diobservasi, 9 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 9 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 4. IRNA 3B – 99,55% Dari 450 petugas yang diobservasi, 2 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 2 petugas tidak identifikasi visual (Kekeliruan Pemeriksaan Uji Fungsi Pleura) 5. Maternitas – 95,90% Dari 439 petugas yang diobservasi, 18 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: a. 18 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) Akar Masalah yang teridentifikasi : 1. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP 2. Kurangnya pemahaman pentingnya prosedur identifikasi pasien 3. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual 4. Minimnya pengawasan langsung dari kepala ruangan Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : 1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Tindak lanjut hasil koordinasi untuk dilakukan pelatihan maupun refresh ulang SPO identifikasi pasien dengan PJ Tim SKP 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien

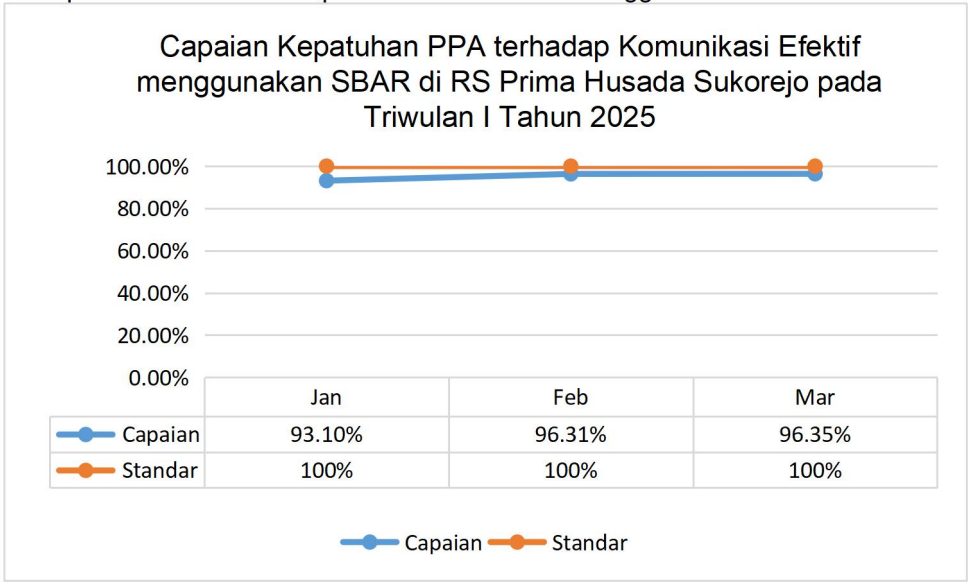
	2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Rata-rata capaian kepatuhan identifikasi pasien pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni 99,24% 2. Sebanyak 5 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu: a. IRNA 2A – 90,32% Dari 310 petugas yang diobservasi, 30 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 17 petugas tidak melakukan secara visual (tidak melihat gelang identitas) 2) 13 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) b. IRNA 2B – 97,11% Dari 450 petugas yang diobservasi, 13 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 11 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 2) 2 petugas tidak melakukan secara lisan (tidak menanyakan nama & TTL) c. IRNA 3A – 98,00% Dari 450 petugas yang diobservasi, 9 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 9 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) d. IRNA 3B – 99,55% Dari 450 petugas yang diobservasi, 2 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 2 petugas tidak identifikasi visual (Kekeliruan Pemeriksaan Uji Fungsi Pleura) e. Maternitas – 95,90% Dari 439 petugas yang diobservasi, 18 petugas tidak melakukan identifikasi sesuai prosedur: 1) 18 petugas tidak identifikasi visual (tidak melihat gelang identitas) 4. Adapun yang tidak mencapai standar dikarenakan: a. Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP b. Kurangnya pemahaman pentingnya prosedur identifikasi pasien c. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual d. Minimnya pengawasan langsung dari kepala ruangan
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Triwulan I tahun 2025 mencapai 99,24%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pendataan dan rekap nama-nama petugas yang tidak melakukan prosedur identifikasi pasien dengan benar selama proses observasi. 2. Menyusun jadwal koordinasi dengan masing-masing petugas yang teridentifikasi tidak patuh (Koordinasi dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab mutu ruangan, secara individu atau kelompok kecil) 3. Tindak lanjut koordinasi dengan pelatihan dan refresh SPO dengan melibatkan Penanggung Jawab Tim Sasaran Keselamatan Pasien (PJ Tim SKP) 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan

Tabel 3.17. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rekap nama petugas yang tidak patuh dalam identifikasi pasien	Mengidentifikasi petugas yang tidak menjalankan prosedur dengan benar	Petugas dari all unit pelayanan	Mengolah data observasi, membuat daftar nama &	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan

				unit		
2	Penjadwalan koordinasi dengan petugas tidak patuh	Melakukan pendekatan personal dan klarifikasi	Petugas yang terdata tidak patuh	Koordinasi secara individu atau kelompok kecil di ruangan masing - masing	Kepala Ruangan, PJ SKP, Tim Mutu	Satu bulan
3	Refresh training & pembahasan ulang SPO Identifikasi pasien	Memberikan pemahaman ulang terkait prosedur identifikasi dua langkah	Seluruh petugas di unit yang tidak patuh	Edukasi kelompok, diskusi SOP, simulasi sederhana	J Tim SKP, SDM Diklat, Kepala Ruangan	Satu bulan
4	Supervisi langsung harian	Memastikan implementasi berjalan secara konsisten di lapangan	Seluruh petugas per shift	Observasi langsung, feedback on the spot,	Kepala Ruangan	Satu bulan

b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Capaian kepatuhan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mengalami peningkatan dari bulan Januari ke Maret. Namun, capaian masih berada di bawah standar yang ditetapkan yakni 100% dengan rata-rata gap sebesar 4,75%. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan terutama dalam konsistensi penerapan SBAR oleh PPA.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Triwulan I Tahun 2025

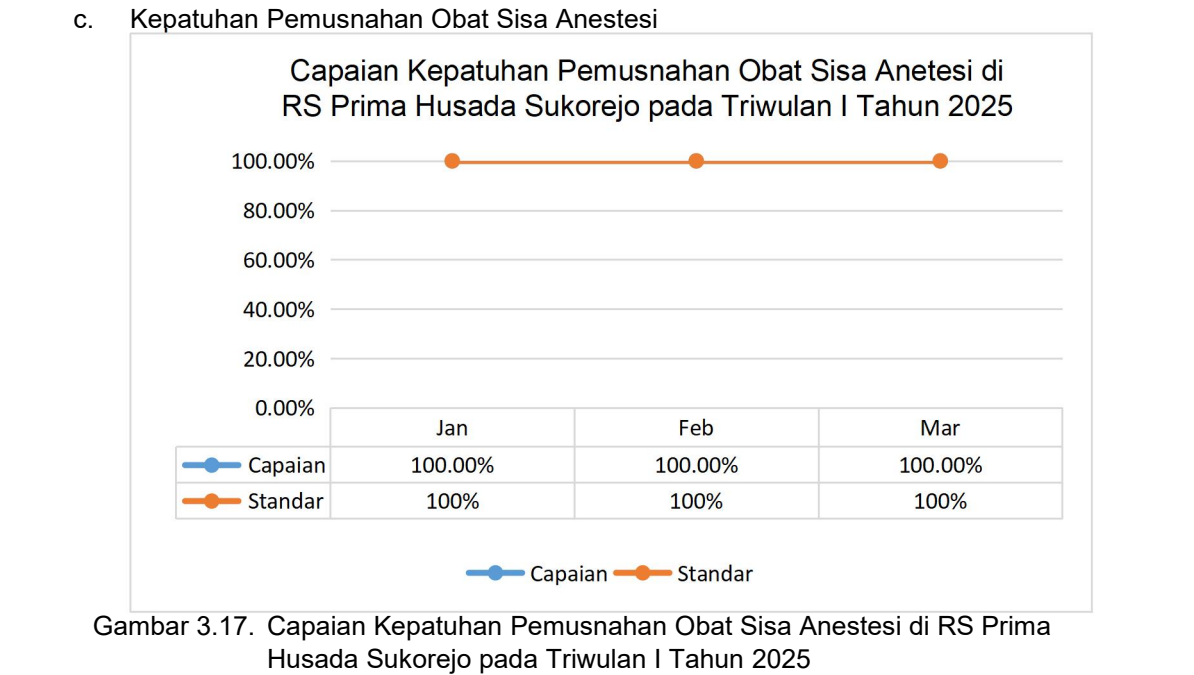
Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 95,25%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Identifikasi Masalah: Tingkat kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) terhadap penggunaan komunikasi efektif dengan format SBAR belum mencapai standar 100%. Hasil monitoring menunjukkan adanya variasi dalam penerapan, terutama pada bagian <i>Assessment</i> dan <i>Recommendation</i>, yang sering tidak lengkap atau tidak sesuai format. 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap penggunaan komunikasi SBAR

	hingga mencapai 100% pada seluruh unit pelayanan, khususnya pada proses serah terima pasien dan komunikasi antar-profesi 3. Rencana Aksi: - Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. - Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Pengisian SBAR oleh petugas - Kepala Unit Rawat Inap melaksanakan monitoring harian terhadap dokumentasi SBAR, terutama pada saat serah terima pasien dan komunikasi antar-shift. - Tim Mutu juga membagikan formulir observasi SBAR untuk membantu mempermudah penilaian kepatuhan.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? - Hasil evaluasi selama pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan petugas dalam menggunakan SBAR, terutama dalam kelengkapan dokumentasi saat serah terima pasien. - Supervisi dari Tim PKRS dan Mutu mengidentifikasi bahwa bagian “Recommendation” masih sering tidak diisi secara optimal, menunjukkan masih adanya kebutuhan penguatan pemahaman tentang pentingnya rekomendasi klinis dalam komunikasi. - Capaian Keterisian SBAR meningkat dari 93,10% (Januari) menjadi 96,35% (Maret), namun belum konsisten mencapai 100%.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR belum mencapai standar dengan capaian Keterisian SBAR meningkat dari 93,10% (Januari) menjadi 96,35% (Maret), namun belum konsisten mencapai 100%. Ini disebabkan adanya form SBAR yang tidak terisi lengkap terutama bagian <i>Assessment</i> dan <i>Recommendation</i>, yang sering tidak lengkap atau tidak sesuai format Follow-up dan Rencana Lanjutan - Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. - Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis.

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi Pelaksanaan Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya.	Supervisi, pemberian umpan balik langsung dan edukasi singkat kepada petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	PKRS, Tim SKP, dan Tim Mutu	1 minggu

2	Monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya	Monitoring dan evaluasi petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	Kepala Ruangan	1 bulan
3	Penyediaan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi SBAR melalui akses mudah terhadap contoh-contoh praktik baik (best practice) yang tersedia secara digital.	Seluruh PPA (perawat, bidan, tenaga medis) di seluruh unit pelayanan, khususnya yang melakukan serah terima pasien, komunikasi antar shift, dan komunikasi antar profesi.	Menyusun beberapa contoh SBAR yang baik dan lengkap yakni dalam bentuk dokumentasi tertulis	Tim SKP, PKRS	1 bulan

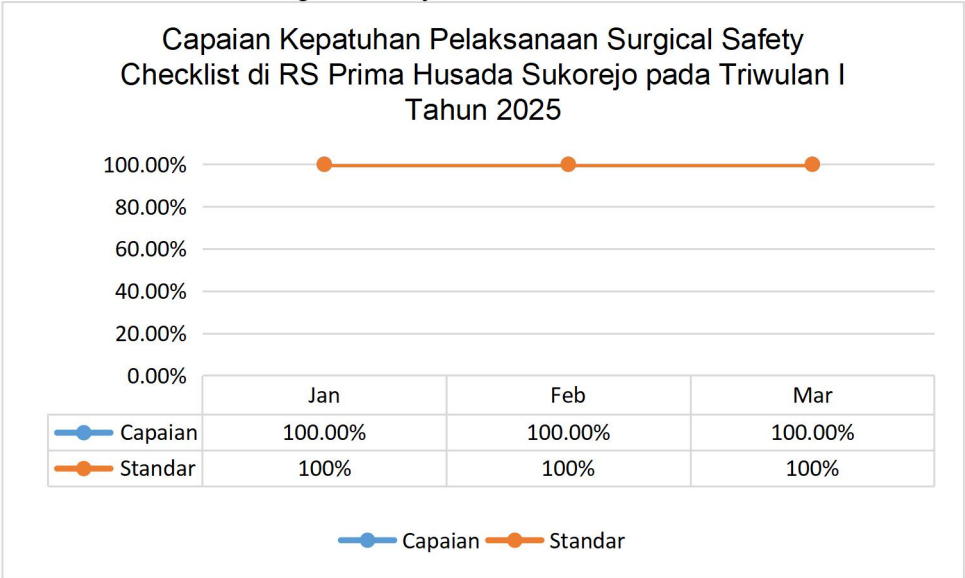


Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 100%. Selama periode Januari hingga maret, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pemusnahan obat sisa anestesi di rumah sakit sudah berjalan **sesuai prosedur**, dan kontrol terhadap risiko penyalahgunaan obat-obatan anestesi sudah diterapkan secara maksimal.

d. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist

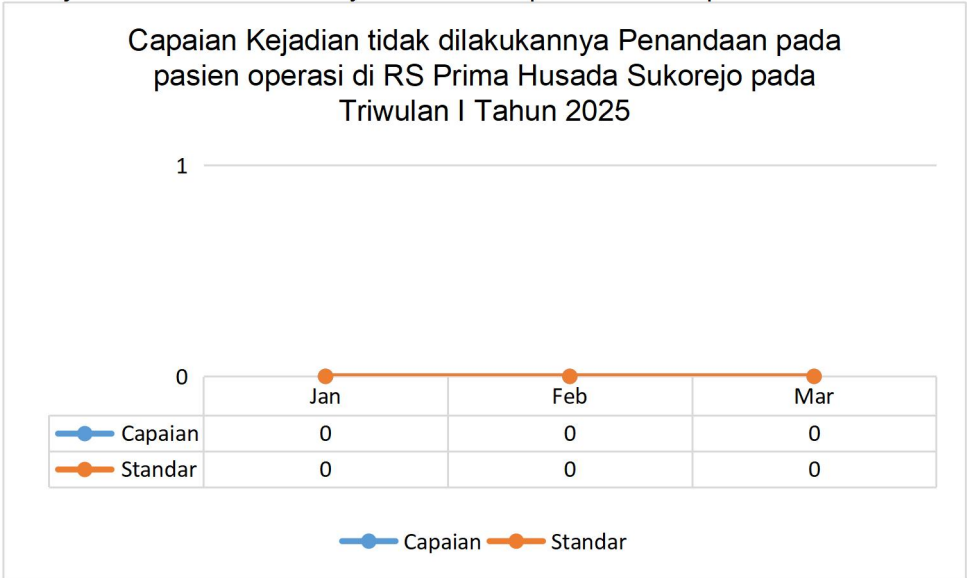


Gambar 3.18. Capaian Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Sfety Checklist di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Selama periode Januari hingga Maret, kepatuhan pelaksanaan Surgical Safety Checklist (SSC) mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur keselamatan pasien pra, saat, dan pasca operasi telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai standar WHO.

e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi

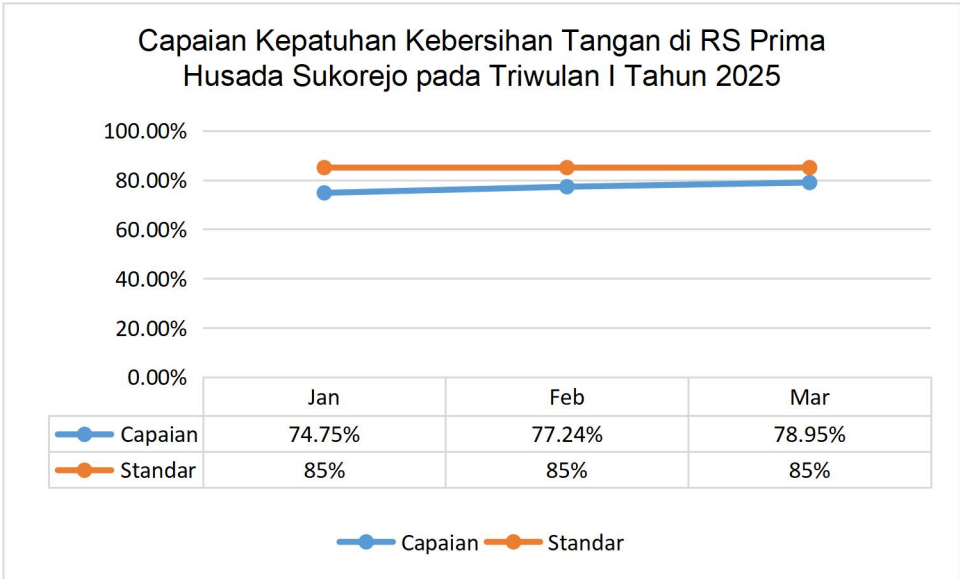


Gambar 3.19. Capaian Kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 mencapai target 100%. Selama periode Januari hingga Maret, **tidak ditemukan kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi**, sehingga angka kejadian tercatat nol (0) dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

f. Kebersihan Tangan



Gambar 3.20. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Triwulan I yakni mencapai 76,98%. Terlihat adanya tren peningkatan dari waktu ke waktu yaitu dari 74,75% pada bulan Januari menjadi 78,95% pada Bulan Maret 2025. Meskipun demikian, rata-rata kepatuhan kebersihan tangan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu ≥85%.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan pada bulan Triwulan I < 85% yakni 76,98%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target ≥85%, dengan rata-rata kepatuhan saat ini sebesar 76,98%. 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan menjadi ≥85% dalam 3 bulan. 3. Rencana Aksi: a. Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO. b. Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan. c. Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI d. Memberikan umpan balik langsung dan bersifat konstruktif kepada tenaga kesehatan. e. Memberikan penghargaan kepada individu atau unit kerja dengan tingkat kepatuhan tertinggi. f. Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.

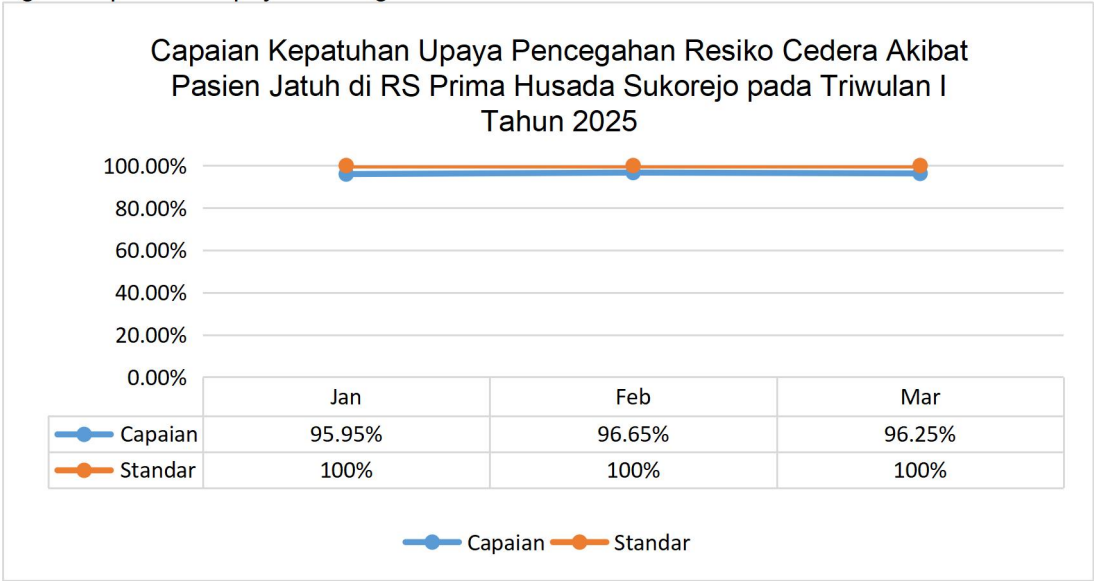
	bulan Januari menjadi 78,95% pada Bulan Maret 2025 3. Target 85% belum tercapai 4. Edukasi dan media edukatif memberikan dampak positif, namun belum cukup signifikan 5. Analisa Penyebab: a. Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO b. Belum semua staf mengikuti edukasi Kepatuhan Kebersihan Tangan di Tahun 2025
Action	1. Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO. 2. Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan. 3. Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI 4. Memberikan penghargaan kepada individu atau unit kerja dengan tingkat kepatuhan tertinggi. 5. Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Melaksanakan edukasi ulang kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai pentingnya kebersihan tangan berdasarkan <i>5 Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO.	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>) agar mencapai target $\geq 85\%$, guna mencegah infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) dan meningkatkan mutu pelayanan.	Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pelayanan pasien, termasuk dokter, perawat, bidan, analis, dan tenaga pendukung lain.	Memberikan pelatihan ulang tentang pentingnya kebersihan tangan dan implementasi <i>5 Moments</i> WHO secara periodik.	Komite PPI	Satu bulan
2	Menyediakan media edukatif seperti poster, banner, atau video yang dipasang di area kerja dan ruang perawatan.	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>)	Seluruh area kerja dan ruang perawatan terdapat media edukasi kebersihan tangan	Pemasangan media edukasi visual seperti poster, banner, atau video di area rawan infeksi.	Komite PPI	Satu bulan
3	Melakukan audit kebersihan tangan secara rutin dan acak oleh Tim PPI	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Melakukan observasi langsung terhadap praktik kebersihan tangan dan memberikan umpan balik individual/unit.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Memberikan	Memastikan bahwa kepatuhan	All petugas melaksanakan	Monitoring dan evaluasi	Ka. Ruang	Satu bulan

	umpan balik langsung dan bersifat konstruktif kepada tenaga kesehatan.	kebersihan tangan sudah dilakukan	kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	berkala	Tim IPCLN	
5	Memberikan pembinaan kepada petugas yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah.	Meningkatkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar WHO (<i>Five Moments of Hand Hygiene</i>)	Petugas dengan tingkat kepatuhan rendah	Pembinaan kepada unit dengan kepatuhan rendah.	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

g. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.21. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada bulan Triwulan I tahun 2025 adalah 96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 4923 petugas yang di observasi ditemukan 183 petugas tidak patuh dari pencegahan resiko jatuh.

Tabel 3.21 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2025

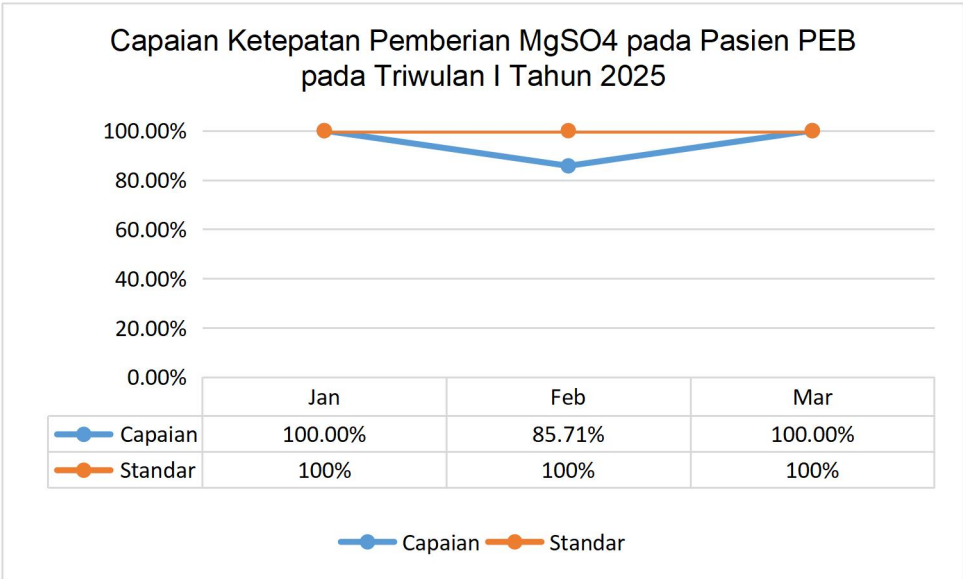
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2025adalah 96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Identifikasi Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 96,28% 2. Ketidaksesuaian antara SPO dan penerapan petugas terkait Pencegahan Resiko Jatuh 3. Tanda resiko jatuh tidak terpasang di kursi roda 4. Hand rail hanya terpasang di salah satu bed pasien Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%.

	Rencana Aksi : 1. Koordinasi dengan kepala ruangan dan Tim SKP untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko jatuh. 2. Pelatihan oleh Tim SKP terkait perhitungan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrinning ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 96,28%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Ketidakesuaian antara SPO dan penerapan petugas terkait Pencegahan Resiko Jatuh 2. Tanda resiko jatuh tidak terpasang di kursi roda 3. Hand rail hanya terpasang di salah satu bed pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan I Tahun 2025 belum sesuai standar yakni Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruangan dan Tim SKP untuk menindaklanjuti petugas yang terdaftar sebagai tidak patuh melakukan asesmen risiko jatuh 2. Pelatihan oleh Tim SKP terkait perhitungan skrinning awal dan ulang risiko jatuh kepada staff yang masih memiliki pengetahuan yang kurang

Tabel 3.22 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelatihan dan refresh tentang risiko jatuh	Mengurangi ketidakpatuhan petugas dalam Upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh	Seluruh staff yang tidak patuh memiliki pengetahuan yang meningkat dan kepatuhan 100%	Koordinasi dengan kepala ruang	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan

2. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
 - a. Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB



Gambar 3.22. Capaian Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 yakni mencapai 95,24%.

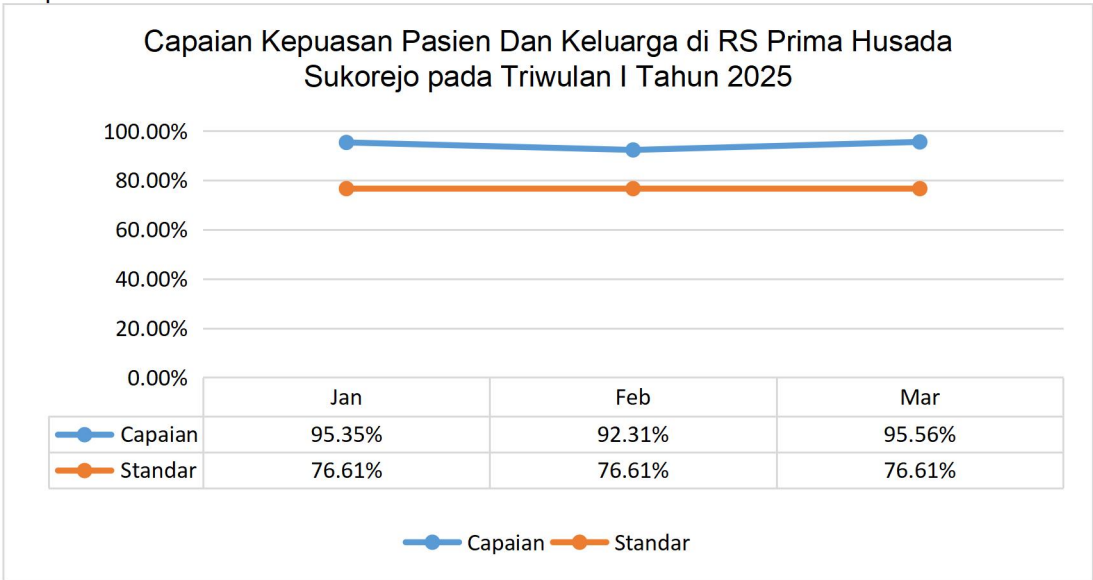
Tabel 3.23 PDSA Capaian Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di Bulan Triwulan I Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di Bulan Triwulan I mencapai 95,24%.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB
Plan	Identifikasi Masalah: Capaian ketepatan pemberian MgSO ₄ pada pasien preeklampsia berat (PEB) selama Triwulan I mencapai 95,24%, sedikit di bawah standar 100%. Terjadi penurunan kepatuhan pada bulan Februari (85,71%) yang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan mutu Tujuan: Kepatuhan ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB dapat tercapai 100% Rencana Aksi: a. Koordinasi dengan DPJP Obgyn, Komite Medik, Kepala Ruang Maternitas dan Kepala Bidang Pelayanan, dalam penanganan pasien PEB untuk memberikan MgSO ₄ . b. Refreshment PPK -CP terkait Pasien dengan Diagnosa Pasien PEB yang wajib diberikan MgSO ₄
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Gejala yang dinampakkan dari ibu hamil, TTV 2. Pasien Ibu Hamil dengan diagnosa PEB 3. Hasil cek Laboratorium dari pasien PEB 4. Pengecekan bisa dilakukan melalui penginputan obat MgSO ₄ di SIMRS
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan rata-rata capaian ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di Bulan Triwulan I mencapai 95,24%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Komunikasi antar dokter dan bidan terkait kondisi pasien kurang efektif 2. Pengawasan kondisi pasien kurang lengkap
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di Bulan Triwulan I mencapai 95,24%. Angka tersebut belum mencapai target 100%. Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan DPJP Obgyn, Komite Medik, Kepala Ruang Maternitas dan Kepala Bidang Pelayanan, dalam penanganan pasien PEB untuk memberikan MgSO ₄ . 2. Refreshment PPK -CP terkait Pasien dengan Diagnosa Pasien PEB yang wajib diberikan MgSO ₄ .

Tabel 3.24 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Koordinasi dengan DPJP Obgyn, Komite Medik, Kepala Ruang Maternitas dan Kepala Bidang Pelayanan, dalam penanganan pasien PEB untuk memberikan MgSO4	Mengurangi ketidaktepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB	Pasien PEB secara keseluruhan dapat diberikan MgSO4	Koordinasi dengan dengan DPJP Obgyn, Komite Medik, Kepala Ruang Maternitas dan Kepala Bidang Pelayanan,	Komite Medik	Satu Bulan
2	Refreshment PPK -CP terkait Pasien dengan Diagnosa Pasien PEB yang wajib diberikan MgSO4	Mengurangi ketidaktepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB	Pasien PEB secara keseluruhan dapat diberikan MgSO4	Focus Group Discussion PPK -CP terkait Pasien dengan Diagnosa Pasien PEB yang wajib diberikan MgSO4	Komite Medik	Satu Bulan

- b. Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS
 - c. Pasien dengan Dengue yang Mendapatkan Pemantauan dan Intervensi Tepat Waktu untuk Mencegah Komplikasi Berat (Seperti Shock atau Perdarahan) dalam 24 Jam Pertama Setelah Diagnosis
 - d. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium
 - e. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan
 - f. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol
 - g. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%
 - h. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)
 - i. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor
 - j. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis
3. Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis RS
- a. Kepuasan Pasien

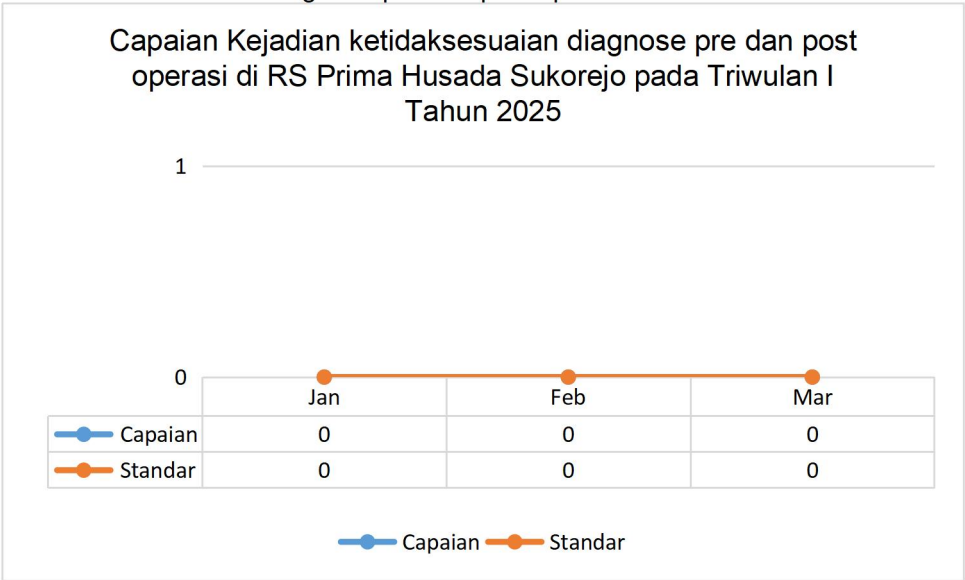


Gambar 3.32. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 94,41%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

- 4. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem
 - a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi



Gambar 3.33. Capaian Kejadian Ketidaksesuaian Diagnosa Pre dan Post Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 capaian kejadian ketidaksesuaian diagnose pre & post operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Angka tersebut sudah mencapai target 0 kejadian.

- b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO

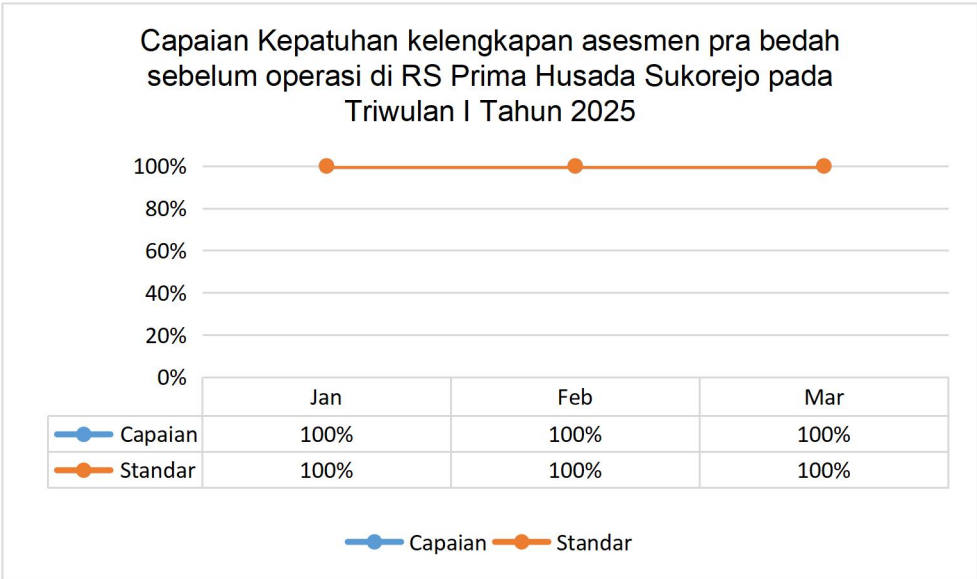


Gambar 3.34. Capaian Angka Kelengkapan Laporan Operasi yang dilakukan di IKO di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 capaian angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100% sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi

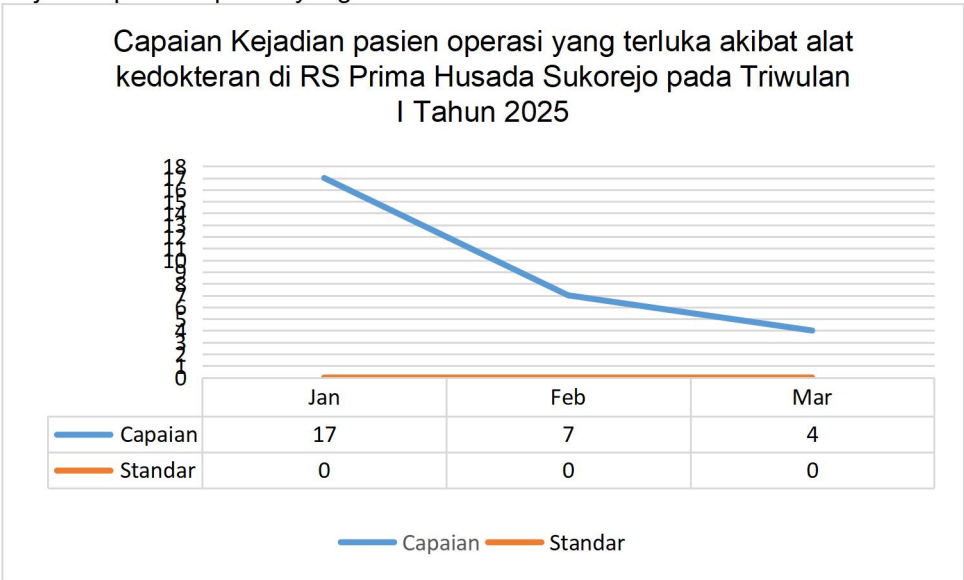


Gambar 3.35. Capaian Kepatuhan Kelengkapan Asesmen Pra Bedah Sebelum Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 capaian kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa prosedur asesmen pra bedah sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin yang terstandarisasi di ruang tindakan/pre-operatif.

- 5. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko
 - a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran



Gambar 3.36. Capaian Kejadian Pasien Operasi yang Terluka Akibat Alat Kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

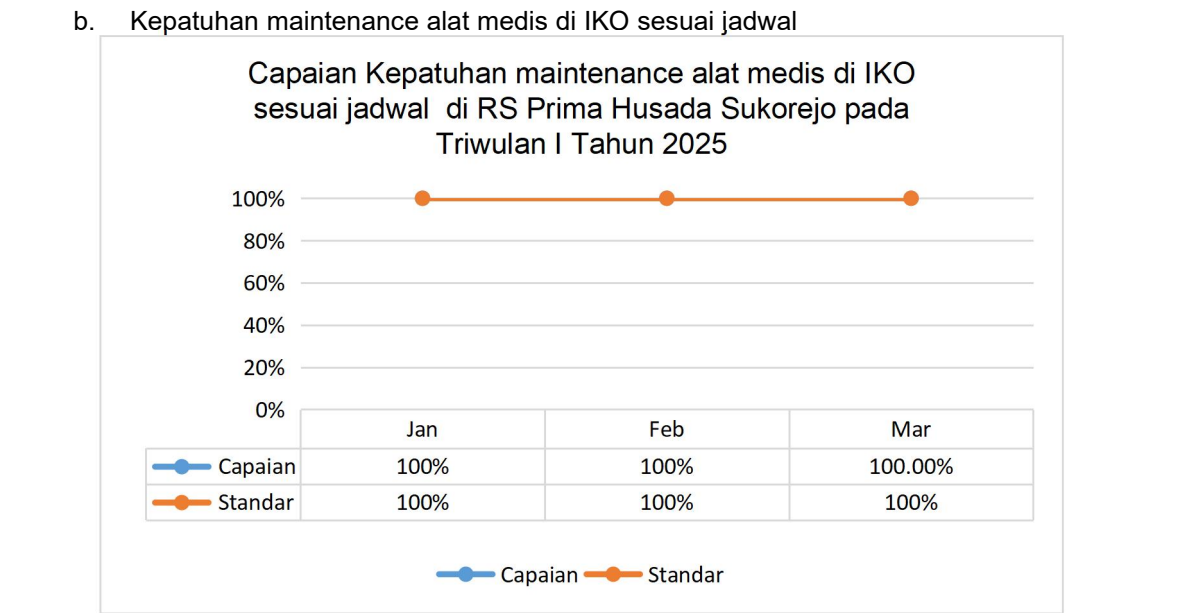
Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan I Tahun 2025 kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo yakni 9 kejadian. Ini disebabkan dikarenakan adanya alat Harum pen memercik saat digunakan dalam operasi.

Problem	Rata-rata capaian kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran yakni 9 kejadian.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran
Plan	Identifikasi Masalah:

	Tingginya angka kejadian pasien terluka akibat alat kedokteran (khususnya harum pen yang memercik saat digunakan dalam tindakan operasi), yang berisiko menimbulkan luka bakar ringan hingga sedang. Analisa Penyebab: - Perubahan desain elektroda: - Pengurangan panjang besi tanpa lapisan cat dari 4 cm menjadi 2 cm mungkin mempengaruhi distribusi panas dan kestabilan arus. - Modifikasi pada Januari 2025 belum sepenuhnya mengatasi masalah ini. - Ketidakseimbangan antara voltase dan performa alat: - Pada voltase rendah, alat tidak cukup kuat untuk memotong jaringan dengan baik. - Pada voltase tinggi, alat berfungsi lebih baik tetapi menimbulkan percikan api dan risiko luka bakar. - Kemungkinan masalah pada bahan atau pelapisan elektroda: - Perubahan spesifikasi bahan atau pelapisan elektroda mungkin mempengaruhi konduktivitas listrik dan stabilitas panas. Tujuan: Menurunkan angka kejadian pasien luka akibat harum pen hingga 0 kejadian per bulan melalui penguatan sistem pengawasan, edukasi teknis, dan evaluasi kualitas alat. Rencana Aksi: - Pemeriksaan menyeluruh oleh tim elektromedis terhadap semua harum pen yang digunakan. - Koordinasi dengan vendor alat medis untuk mengkaji ulang desain dan kualitas bahan elektroda
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Audit bulanan terhadap kejadian luka akibat alat dan uji coba performa alat secara acak. - Mulai Maret 2025, diberlakukan formulir pemakaian harum pen di IKO Bedah
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Berdasarkan data Januari hingga Maret 2025, rata-rata kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran adalah 9 kejadian. Meskipun terjadi tren penurunan, angka ini masih jauh dari standar 0 kejadian yang ditetapkan rumah sakit. Hal ini disebabkan antara lain: 4 kejadian disebabkan oleh alat lama yang belum sempat diganti pada awal bulan Maret Tahun 2025.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan data Januari hingga Maret 2025, rata-rata kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran adalah 9 kejadian. Meskipun terjadi tren penurunan, angka ini masih jauh dari standar 0 kejadian yang ditetapkan rumah sakit. Follow-up dan Rencana Lanjutan - Pemeriksaan menyeluruh oleh tim elektromedis terhadap semua harum pen yang digunakan. - Koordinasi dengan vendor alat medis untuk mengkaji ulang desain dan kualitas bahan elektroda - Penanggung jawab alat dan tim Mutu IKO menggunakan formulir pemakaian harum pen di IKO Bedah

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pemeriksaan menyeluruh oleh tim elektromedis terhadap semua harum pen yang digunakan.	Menjamin bahwa semua alat harum pen yang digunakan dalam tindakan operasi berada dalam	Seluruh harum pen (<i>electrocautery pen</i>) yang tersedia dan digunakan di ruang operasi RS Prima Husada Sukorejo	Koordinasi dengan vendor untuk penarikan, penggantian, atau pengembalian batch	Tim ATEM, Kepala Ruang IKO, Jajaran Direksi RS Prima Husada Sukorejo	Satu Bulan

		kondisi layak pakai, aman, dan tidak menimbulkan risiko luka bakar atau percikan api.				
2	Koordinasi dengan vendor alat medis untuk mengkaji ulang desain dan kualitas bahan elektroda	Memastikan bahwa desain dan spesifikasi material elektroda pada harum pen telah sesuai dengan standar keamanan dan efektivitas tindakan bedah, serta tidak menimbulkan risiko luka atau percikan	• Vendor penyedia alat harum pen • Seluruh harum pen yang digunakan di ruang operasi	• Permintaan uji teknis ulang dari pihak vendor terhadap batch produk terakhir. • Peninjauan ulang perjanjian kerja sama jika ditemukan ketidaksesuaian mutu	Vendor, Tim ATEM	Satu Bulan
3	Penanggung jawab alat dan tim Mutu IKO menggunakan formulir pemakaian harum pen di IKO Bedah	Penggunaan formulir pemakaian harum pen di Instalasi Kamar Operasi (IKO) Bedah untuk memantau penggunaan, kondisi, dan keamanan alat setiap tindakan operasi	Seluruh tindakan operasi yang menggunakan harum pen di IKO	Pembuatan formulir pemakaian harum pen di IKO Bedah dan rekap mingguan oleh Tim Mutu IKO untuk analisa tren dan laporan ke manajemen	Tim Mutu IKO	Satu Bulan



Gambar 3.37. Capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan I Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Angka tersebut sudah mencapai target 100%. Kepatuhan 100% selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan bahwa program maintenance alat medis di IKO berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal. Tidak ditemukan keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan preventive maintenance maupun kalibrasi alat-alat kritis

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.16 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Triwulan I Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,7%	100%	100%	100%	99,90%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	58,57%	77,78%	83,78%	≥ 85 %	73,38%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	91,86%	92,31%	95,56%	≥ 76,61 %	93,24%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	98,65%	100%	100%	100%	99,55%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR		95%	87,74%	100%	91,37%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi yang dimusnahkan
3	Pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	85%	100%	100%	100%	95,00%	PDSA
2	Kematian pasien< 24 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	18/1785	17/1768	9/1860	≤ dua per seribu	0,008	PDSA
3	Kelengkapan pengisian pengkajian medis E-Rm.	85%	99,29%	98,06%	100%	94,12%	PDSA
4	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	87%	95,71%	97,42%	100%	93,38%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
5	Kelengkapan pengisian LOP	85%	90,71%	96,77%	100%	90,83%	PDSA
6	Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	84,66%	100%	100%	100%	94,89%	PDSA
7	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit	70%	100%	100%	100%	90%	PDSA
8	Respon time pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam	80%	100%	100%	100%	93,33%	PDSA

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.22 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	78,23%	82,78%	≥ 85 %	87,00%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	61,67%	69,17%	67,50%	100%	66,11%	PDSA
4	Kepuasan pasien	92,44%	92,31%	95,56%	≥ 76,61%	93,44%	Dipertahankan
5	Waktu tunggu rawat jalan	71,25%	68,24%	59,17%	≥ 80%	66,22%	PDSA
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	88,89%	98,89%	100%	95,93%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
2	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
3	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		
4	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
5	Ketepatan				≥ 90 %		

	Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor						
6	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan ≥ 30 menit	13,45%	13,87%	1,94%	0%	9,75%	PDSA
2.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan	100%	99,09%	100%	100%	99,70%	PDSA
4.	Kelengkapan Form E-RM PRMRJ Pasien	93,33%	100%	100%	100%	97,78%	PDSA

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	78,89%	95,45%	94,55%	100%	89,63%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	50%	71,34%	≥ 85 %	73,78%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	95,56%	95,45%	95,45%	100%	95,49%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61 %	100,00%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	45,56%	85,45%	86,36%	≥ 80%	72,46%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	33,33%	100%	98,04%	100%	77,12%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan	100%	96,88%	95,24%	100%	97,37%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	SBAR						
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%			22,22%	≥ 70%	22,22%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,72%	1,64%	1,19%	≤ 0,24 %	1,52%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	5 kejadian	5 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	93,33%	91,82%	95,45%	100%	93,53%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	87,5%	100%	94,55%	100%	94,02%	PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	93,55%	98,57%	98,71%	100%	96,94%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	78,02%	≥ 85 %	92,67%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	94,84%	92,86%	90,97%	100%	92,98%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	-	90%	≥ 76,61 %	95%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	76,13%	65,71%	64,52%	≥ 80%	68,79%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak ada diagnosa tunggal	Tidak ada diagnosa tunggal	100%	≥ 80%	100%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	98,77%	100%	99,59%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	92,26%	88,57%	85,81%	100%	88,88%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi				100%		
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah				≥ 90%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.						
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				$\geq 95\%$		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				$\leq 5\%$		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				$\geq 95\%$		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c $< 7\%$			16,67%	$\geq 70\%$	16,67%	dipertahankan
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				$\geq 95\%$		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				$\geq 90\%$		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $< 140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				$\geq 75\%$		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,69%	0,27%	1,34%	$\leq 0,24\%$	1,10%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	5 Kejadian	1 Kejadian	2 Kejadian	0 kejadian	3 Kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian	92,26%	75,71%	70,97%	100%	79,65%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam						
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	93,55%	87,86%	80%	100%	87,14%	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Bulan Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	97,42%	98,57%	98,06%	100%	98,02%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	76,36%	80,77%	88,41%	≥ 85 %	81,85%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,77%	97,86%	96,13%	100%	96,92%	PDSA
4	Kepuasan pasien	95,45%	88,57%	95,24%	≥ 76,61 %	93,09%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	82,58%	82,14%	90,32%	≥ 80%	85,01%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak ada diagnosa tunggal	99,29%	Tidak ada diagnosa tunggal	≥ 80%	99,29%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	88,00%	100%	93,10%	100%	93,70%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,06%	97,86%	97,42%	100%	97,78%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi				100%		
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis				≥ 95%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	atau konfirmasi laboratorium						
5	Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS		100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%				≥ 70%		
7	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
8	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
9	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0%	0%	0,61%	≤ 0.24 %	0,20%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	1 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	1 kejadian	3 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	97,42%	97,14%	96,77%	100%	97,11%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.66 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	98,71%	100%	99,57%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	87,50%	44,44%	41,43%	≥ 85 %	57,79%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	99,35%	100%	100%	100%	99,78%	PDSA
4	Kepuasan pasien	92%	100%	100%	≥ 76,61 %	97,33%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter	63,64%	44,29%	50,97%	≥ 80%	52,97%	PDSA

	≤14.00 WIB						
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	100%	100%	≥ 80%	100,00%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	90%	96,77%	100%	95,59%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	72,08%	100%	99,35%	100%	90,48%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%			0%	≥ 70%	0%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		

10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,35%	0%	1,53%	≤ 0.24 %	0,63%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	1 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	66,23%	62,14%	62,58%	100%	63,65%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.80 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	44,44%	-	≥ 85 %	72,22%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	0%	3,43%	1,08%	≤ 5%	1,50%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	95,35%	92,31%	95,56%	≥ 76,61 %	94,41%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	-	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Ketepatan pemberian	-	-	-	100%	-	Tidak ada pemberian

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	MgSO4 Pada Pasien PEB						MgSO4 di Ruang IKO
4	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor	100%	100%	100%	≥ 90 %	100%	Dipertahankan
5	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	17 kejadian	7 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	9 kejadian	PDSA (Percikan dari Harum Pen)
9	Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi (30 menit)	-	-	-	100%	-	Belum diisi
2.	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari	-	-	-	100%	-	Belum diisi
3.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.81 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada sisa obat anestesi
Indikator Mutu Prioritas Unit							

1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0%	0%	0%	≤ 6 %	0%	Dipertahankan
2	Kejadian reaksi anestesi	0%	0%	0%	≤ 6 %	0%	Dipertahankan
3	Kejadian salah penempatan	0%	0%	0%	≤ 6 %	0%	Dipertahankan
4	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka efek samping selama sedasi moderat	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.82 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	96,77%	96,35%	94,56%	100%	95,89%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	80%	71,79%	68,18%	≥ 85 %	73,32%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	88,00%	100%	97,22%	100%	95,07%	PDSA
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	89%	88%	100%	> 80%	92,33%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	85,29%	85,98%	94,12%	≥ 80%	88,46%	Dipertahankan
7	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	99,70%	96,88%	98,70%	≥ 80%	98,43%	Dipertahankan
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61 %	100,00%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan DPJP	100%	85,71%	100%	100%	95,24%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	dalam penggunaan MgSO ₄ pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi						
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklamsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kepatuhan Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala III segera setelah bayi lahir	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian korioamnionitis pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini prematur	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kepatuhan pemberian antibiotika profilaksis sebelum operasi SC < 1 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
13	Kepatuhan Pemeriksaan DJJ saat kala II	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

9. PONEK

Tabel 3.86 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	100%	100%	100%	> 80%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	≥ 76,61 %	-	Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	-	-	-	100%	-	Tidak ada pasien HPP di Ponek
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponek yang terlatih	-	-	100%	100%	100%	dipertahankan
3	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.87 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,53%	100%	100%	100%	99,51%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	72,73%	89,02%	95,70%	≥ 85%	85,82%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	88,89%	100%	100%	100%	96,30%	PDSA

5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	80,88%	77,05%	89,74%	≥ 80%	82,56%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada pasien dengan Diagnosa tunggal
7	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	96,55%	100%	100%	100%	98,85%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	5 kejadian	4 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	PDSA
2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500-2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	100%	100%	92,31%	100%	97,44%	PDSA
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

11. ICU

A. ICU

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	75%	≥ 85%	91,67%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	50%	70,97%	53,85%	≥ 80%	58,27%	PDSA
5	Kepatuhan Penggunaan Alat	100%	100%	79,17%	100%	93,06%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	Pelindung Diri						
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	-	-	-	≥ 95%	-	Tidak ada pasien ca mammae
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	0%	≤ 3 %	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

B. ICU ISOLASI

Tabel 3.93 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	75%	≥ 85%	87,50%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	≥ 80%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	79,17%	100%	89,59%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS	Tidak ada pasien ICU Isolasi	Tidak ada pasien broncho pneumonia	Tidak ada pasien broncho pneumonia	100%	Tidak ada pasien bronchopneumonia	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	Tidak ada pasien ICU Isolasi	100%	100%	≥ 80%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan Pembersihan dan	Tidak ada pasien ICU	100%	100%	≥ 95%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	desinfeksi ruangan	Isolasi					

12. RADIOLOGI

Tabel 3.94 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	100%	-	≥ 85%		Belum diisi
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	60%	-	66,67%	100%	63,34%	PDSA
5	Kepuasan pasien	-	-		≥ 76,61%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	-	97,04%	91,61%	100%	94,33%	PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	-	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	-	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	-	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

13. LABORATORIUM

Tabel 3.95 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	93,75%	≥ 85%	97,92%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	83,33%	55,56%	52,38%	100%	63,76%	PDSA
4	Kepuasan pasien				≥76,61%		
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	99,97%	100%	100%	99,99%	Dipertahankan
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0,04%	0,04%	0,07%	0%	0,05%	PDSA
4	Angka	3,70%	6,61%	6,06%	0%	5,46%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	ketidaklengkapan form permintaan laboratorium						
5	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	0	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥ 30 menit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	0%	0%	< 0,01%	0%	Dipertahankan
12	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.99 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	-	-	≥ 85%	-	Belum diobservasi
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	99,17%	100%	100%	99,59%	PDSA
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	≥ 76,61%	-	Belum ada pasien yang scan barcode
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	-	-	100%	-	Belum diobservasi
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	pengajian medis & protokol pasien rehab medik						
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.100 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	72,41%	-	≥ 85%	86,21%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	-	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	95,35%	92,31%	95,56%	≥ 76,61 %	94,41%	Dipertahankan
5	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat yang dimusnahkan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	75%	66,67%	96,67%	100%	79,45%	PDSA
2	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	75%	77,78%	86,40%	100%	79,73%	PDSA
3	Kejadian kesalahan pernberian obat	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	8 kejadian	18 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	7 kejadian	PDSA
5	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik	0 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA

16. GIZI

Tabel 3.101 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			

Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	62,50%	78,26%	97,14%	≥ 85%	79,30%	PDSA
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	83,33%	75,71%	81,16%	100%	80,07%	PDSA
4	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	≥ 76,61%	94,41%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	≥ 90 %	100%	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	19%	22%	14%	≤ 20 %	18,33%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%	100%	0%	Belum ada maintenance

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.102 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	76,61%	94,41%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	95,87%	92,56%	96,69%	100 %	95,04%	PDSA
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	63,22%	64,29%	63,03%	100 %	63,51%	PDSA
3	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	4 kejadian	4 kejadian	5 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	PDSA
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	68%	65%	72%	100%	68,33%	PDSA
6	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24	15,46%	15,46%	24,55%	0%	18,49%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	jam						
7	Kelengkapan NIK di data pasien	96,76%	97,02%	97,40%	100%	97,06%	PDSA
8	Kelengkapan General Concent	98,51%	97,79%	96,95%	100%	97,75%	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	6,45%	5%	1,94%	100%	4,46%	PDSA
10	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.103 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Baku mutu limbah cair	a. BOD 13,54 mg/l b. COD < 41,13 mg/l c. TSS < 22,4 mg/l d. PH 7,06	a.BOD 9,54 mg/l b. COD < 26,08 mg/l c. TSS < 5,86 mg/l d. PH 7,46	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	Dipertahankan
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan
3.	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	0%	44,11%	100%	44,11%	1 Tahun
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

19. SDM

Tabel 3.104 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	0%	45,26%	6,67%	100 %	17,31%	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	1,49%	5,96%	22,48%	≥ 60 %	22,48%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	1,31%	0,43%	0,43%	≤10% / bulan	0,72%	Dipertahankan
4.	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	19,11%	10,64%	7,28%	0%	12,43%	PDSA
6.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD :	64,13%	64,13%	65,02%	100%	64,43%	PDSA

	BLS/PPGD /GELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU						
7.	Kepuasan karyawan	-	-	-	≥ 80 %	-	Belum Diisi
8.	Respon time penanganan masalah karyawan ≤ 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.105 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariatan	100%	100%	96,67%	100%	98,89%	PDSA
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	96,55%	97,56%	100%	100%	98,04%	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

21. DRIVER

Tabel 3.106 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kepatuhan waktu pengantaran penggunaan ambulance < 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulace	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.107 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian pemulasaraan jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.108 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
ATEM							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	100%	100%	≤ 80%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	-	-	-	100%	-	Tidak ada alat medis kritikal
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal	-	-	-	100%	-	Alat di Kalibrasi di Bulan Agustus
IPSRS							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat non medis ≤ 15 menit	99,01%	28,76%	60%	100%	62,59%	PDSA
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset ≤ 10 detik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)				100%		Belum diisi

24. LAUNDRY

Tabel 3.109 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan penggunaan APD	70%	70%	70%	100%	70%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kejadian linen yang hilang	2 kejadian	11 kejadian	14 kejadian	0 kejadian	9 kejadian	PDSA
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	3 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

25. CSSD

Tabel 3.110 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	100%	70%	100%	100%	90,00%	PDSA
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
	sesuai standar 135 derajat (merubah pedoman di 2025)						
3.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	96,43%	100%	90,48%	100%	95,64%	PDSA
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. Breathing circuit 2. Begging 3. LMA 4. JR	100%	100%	100%	100%	100%	Hasil Swab Instrumen Negative
5.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor	98,67%	99,88%	99,23%	100%	99,26%	PDSA
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito)	99,56%	98,67%	98,46%	100%	98,90%	PDSA
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA

26. CLEANING SERVICE

Tabel 3.111 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Penggunaan APD	27,27%	100%	100%	100%	75,76%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Respon time	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

	petugas kebersihan ≤ 15 menit						
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤3/4 Tempat sampah	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

27. KEAMANAN

Tabel 3.112 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	0 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	90,32%	100%	100%	100%	96,77%	PDSA
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	96,07%	97,74%	100%	97,94%	PDSA
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	74 kejadian	139 kejadian	234 kejadian	0 kejadian	149 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit	98,92%	99,88%	98,60%	100%	99,13%	PDSA
7.	Kepatuhan penggunaan id card staff di area rumah sakit	80%	62,50%	60,43%	100%	67,64%	PDSA

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.113 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	-	95,12%	94,79%	100%	94,96%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka kepatuhan pengajuan pengadaan ke PT ≤ (lihat SPO)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.114 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	74,75%	77,24%	78,95%	≥ 85%	76,98%	PDSA
2.	Kepatuhan APD	89,64%	89,87%	84,84%	≥ 100%	88,12%	PDSA
Indikator Mutu Komite PPI							
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	61,60%	82,75%	81,80%	60 %	75,38%	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	3,55%	1,07%	3,87%	75 %	2,83%	PDSA
3.	Angka infeksi daerah operasi	0%	0,89%	1,19%	≤ 1,5%	0,69%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	52,46%	87,50%	97,14%	100%	79,03%	PDSA
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	55,24%	63,69%	60,00%	100%	59,64%	PDSA
7.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	87,10%	83,00%	90,91%	100%	87,00%	PDSA
8.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	47,13%	58,53%	59,26%	100%	54,97%	PDSA
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	1,24%	1,37%	1,51%	100%	1,37%	PDSA
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	27,78%	47,22%	55,88%	100%	43,63%	PDSA

30. PKRS

Tabel 3.115 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	39,29%	65,18%	64,29%	100%	56,25%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	95,65%	97,62%	100%	97,76%	PDSA
3.	Ketepatan pengisian form	24,66%	65,22%	97,62%	100%	62,50%	PDSA

	edukasi terintegrasi						
4.	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)	41,07%	65,18%	65,18%	100%	57,14%	PDSA
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR (CPPT, HO, SBAR)	100%	75%	87,76%	100%	87,59%	PDSA
6.	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

31. ASURANSI CENTER

Tabel 3.116 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	kepatuhan DPJP dalam penegakan diagnosa sesuai dengan ketentuan BPJS	94,55%	98,08%	95,39%	80%	96,01%	Dipertahankan
2.	kelengkapan berkas penunjang klaim pelayanan	98,95%	98,52%	98,40%	100%	98,62%	PDSA
3.	Kepatuhan petugas rawat inap terhadap penyetoran rekam medis BPJS Kesehatan < 24jam	90,63%	91,63%	94,62%	100%	92,29%	PDSA
4.	kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	84,66%	90,63%	84,33%	100%	86,54%	PDSA
5.	Kejadian berkas pending klaim pasien BPJS	260 kejadian	226 kejadian	262 kejadian	0	249 kejadian	PDSA

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.117 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kepuasan Pasien MCU	100%	100%	100%	≥ 76,61%	100%	Dipertahankan
2.	Ketidakpatuhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	0%	0,93%	0,03%	10% / tahun	0,32%	Tahunan

33. CSO

Tabel 3.118 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Respon time CSO <30 mnt (WA)	16,27%	15,96%	15,13%	100%	15,79%	PDSA
2.	Ketepatan perubahan jadwal dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	Adanya SE tentang Penyesuaian Kebijakan Sesuai HFIS Versi 6.0

34. MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.119 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	95,35%	92,31%	95,56%	≥ 76,61%	94,41%	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP							
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	90,07%	100%	100%	100%	96,69%	PDSA
4	Angka kelengkapan form Dischard planning	90,07%	100%	100%	100%	96,69%	PDSA

35. TB di IRJA

Tabel 3.120 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB	100%	100%	100%	≥ 90%	100%	Dipertahankan

36. KEUANGAN

Tabel 3.122 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10 menit	0%	0%	0%	<5%	0%	Dipertahankan

3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Jumlah piutang $\geq$ 60 hari	2,39%			0%		PDSA

37. TIM HIV

Tabel 3.123 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	100%	100%	100%	$\geq$ 90%	100%	Dipertahankan

38. KB

Tabel 3.124 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	100%	100%	100%	100,00%	Dipertahankan
2.	Angka terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca keguguran	8,90%	17,74%	10,87%	50%	12,50%	PDSA
3.	Semua ibu melahirkan dan curretage mendapatkan KIE KB	98,01%	100%	100%	100%	99,34%	PDSA
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	96,75%	100%	100%	30%	98,92%	Dipertahankan

39. STUNTING

Tabel 3.125 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	100%	0%	0%	100%	33,33%	PDSA
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3bulan sekali	-	-	-	100%		Triwulanan
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

40. IT - SIM RS

Tabel 3.126 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		Januari	Februari	Maret			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	83,33%	100%	90%	100%	91,11%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	58,14%	50%	46,15%	100%	51,43%	PDSA